

PUNTO 01 • CABEZA

Vértice

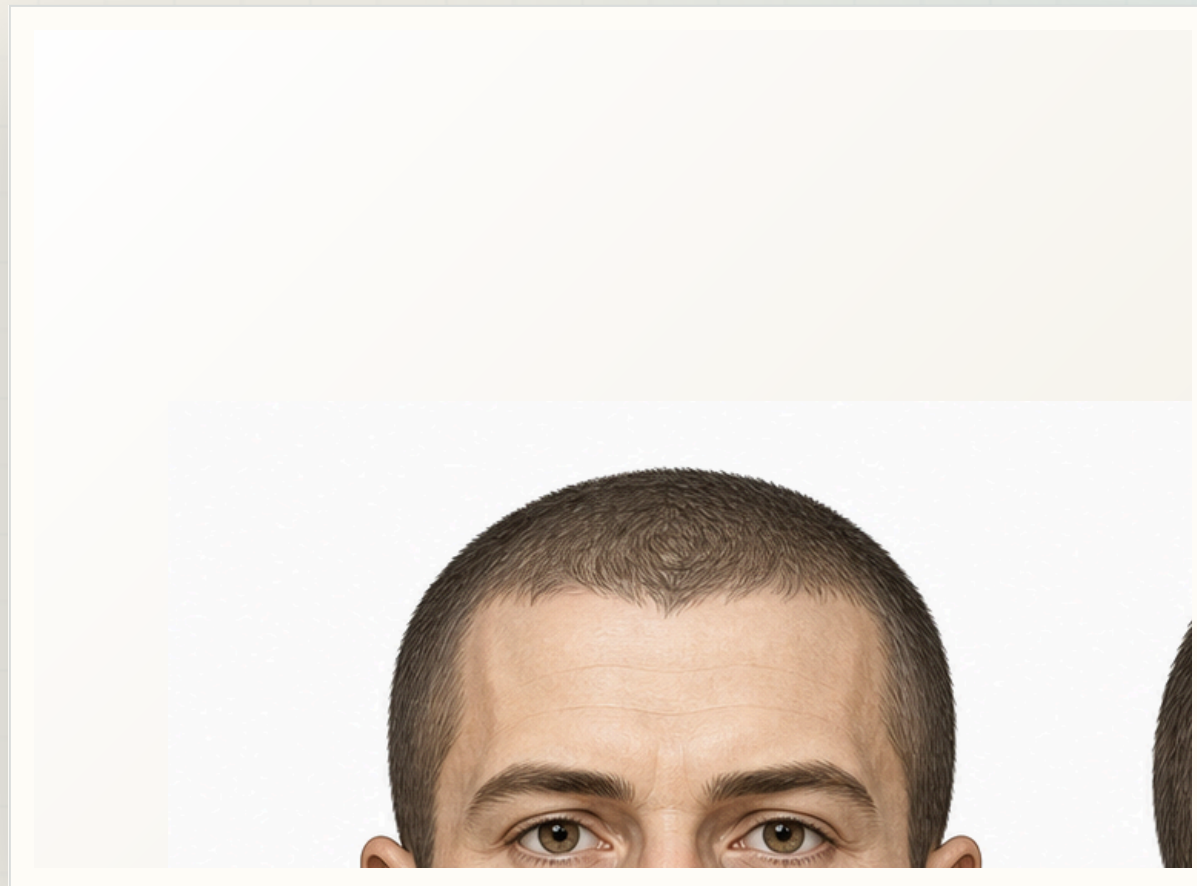
La región más superior de la bóveda craneal, sobre la línea media.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Línea media sagital del cráneo.
- Punto más alto de la cabeza en posición anatómica.
- Aproximadamente equidistante de ambos pabellones auriculares.

RELACIÓN SUPERFICIAL Piel cabelluda sobre la calvaria; no corresponde a una sutura única en todas las personas.

PRECISIÓN Se trabaja como una zona superior, no como un punto milimétrico.



PUNTO 02 • CABEZA

Occipital

Superficie posterior del cráneo cubierta por el hueso occipital.

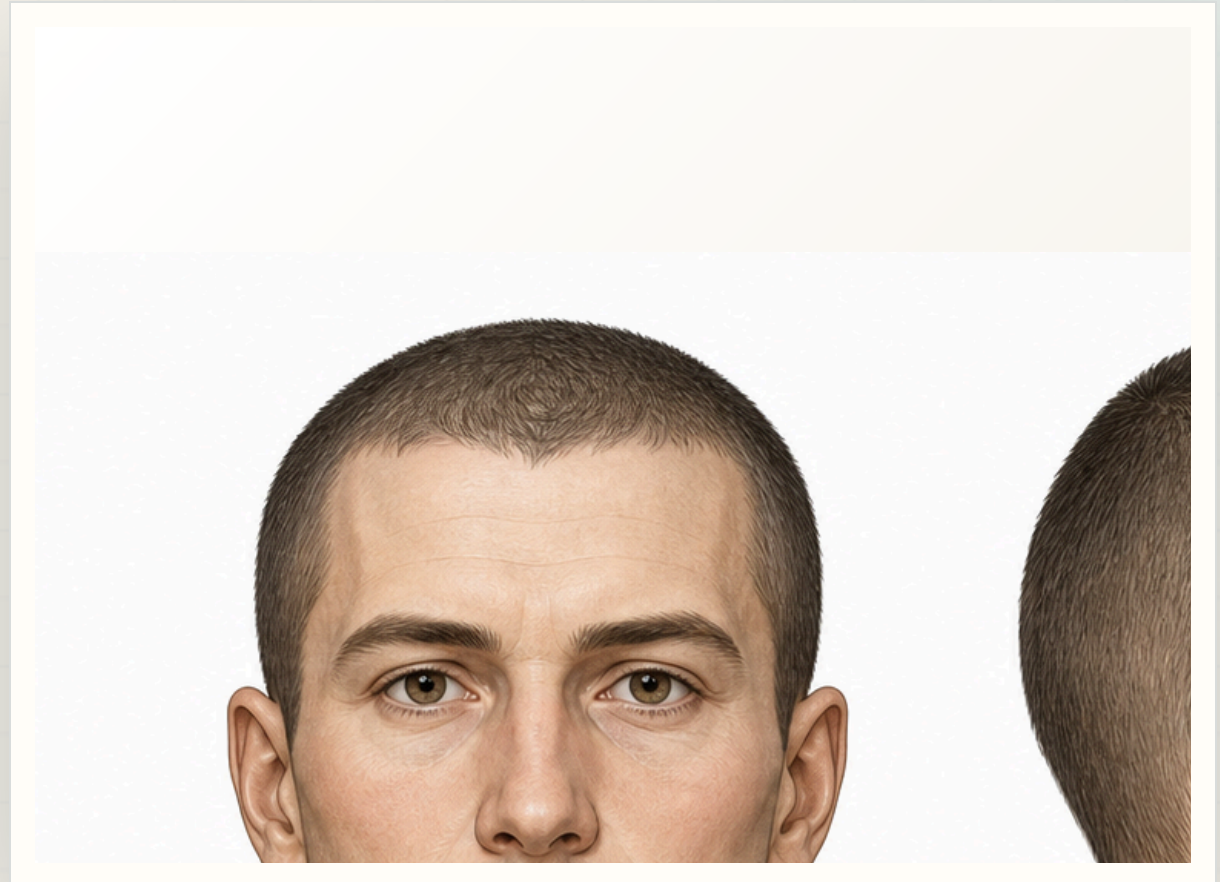
REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Protuberancia occipital externa en la línea media.
- Líneas nucales superior e inferior.
- Región posterior situada por encima de la unión cráneo–cuello.

RELACIÓN SUPERFICIAL Piel cabelluda, fascia y hueso occipital.

PRECISIÓN

No confundir con la depresión suboccipital, que está debajo del occipucio.



PUNTO 03 • CABEZA

Glabella

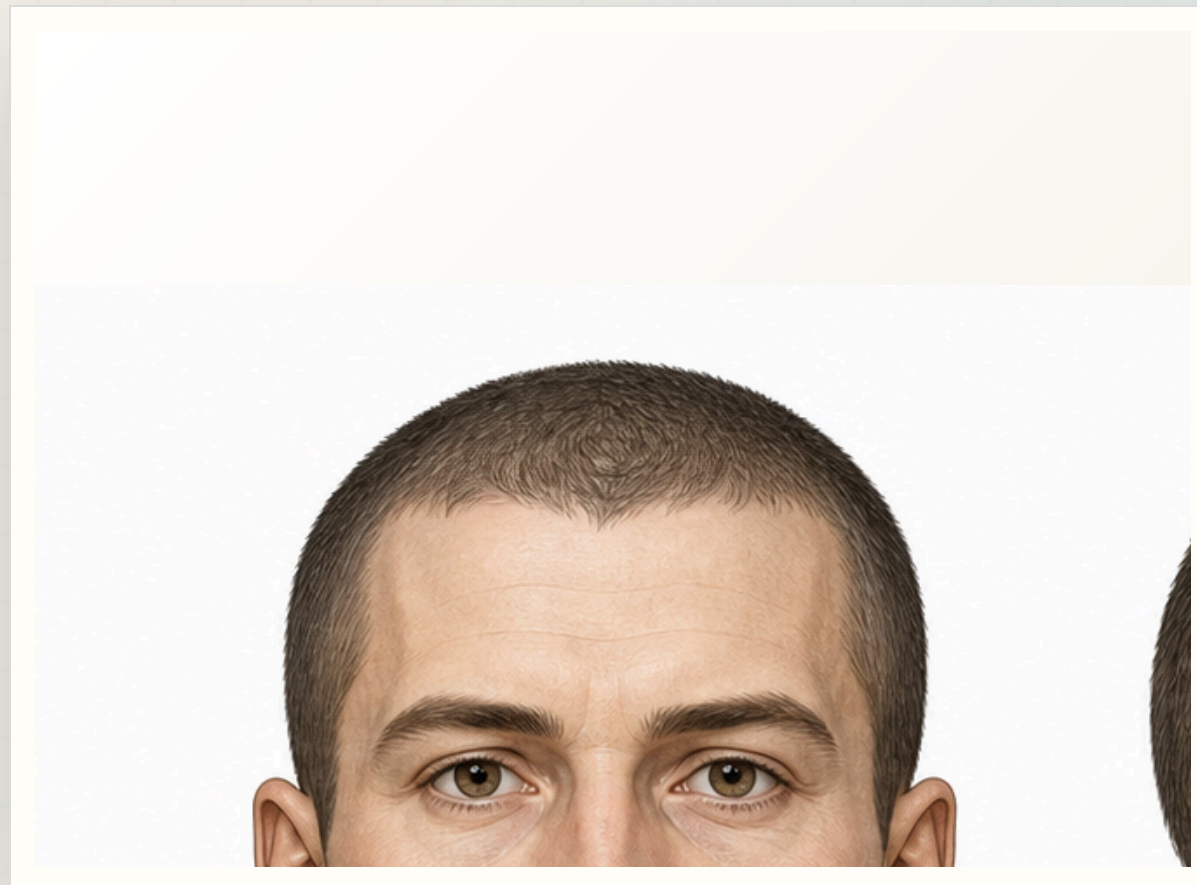
Prominencia lisa de la línea media frontal, entre las cejas y por encima de la raíz nasal.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Entre los arcos superciliares.
- Superior al nasion.
- Sobre el hueso frontal, en la línea media.

RELACIÓN SUPERFICIAL Piel y periostio frontal; forma el extremo anterior del dipolo sagital.

PRECISIÓN No es bilateral: su complementario operativo es la depresión suboccipital.



PUNTO 04 • CABEZA

Depresión suboccipital

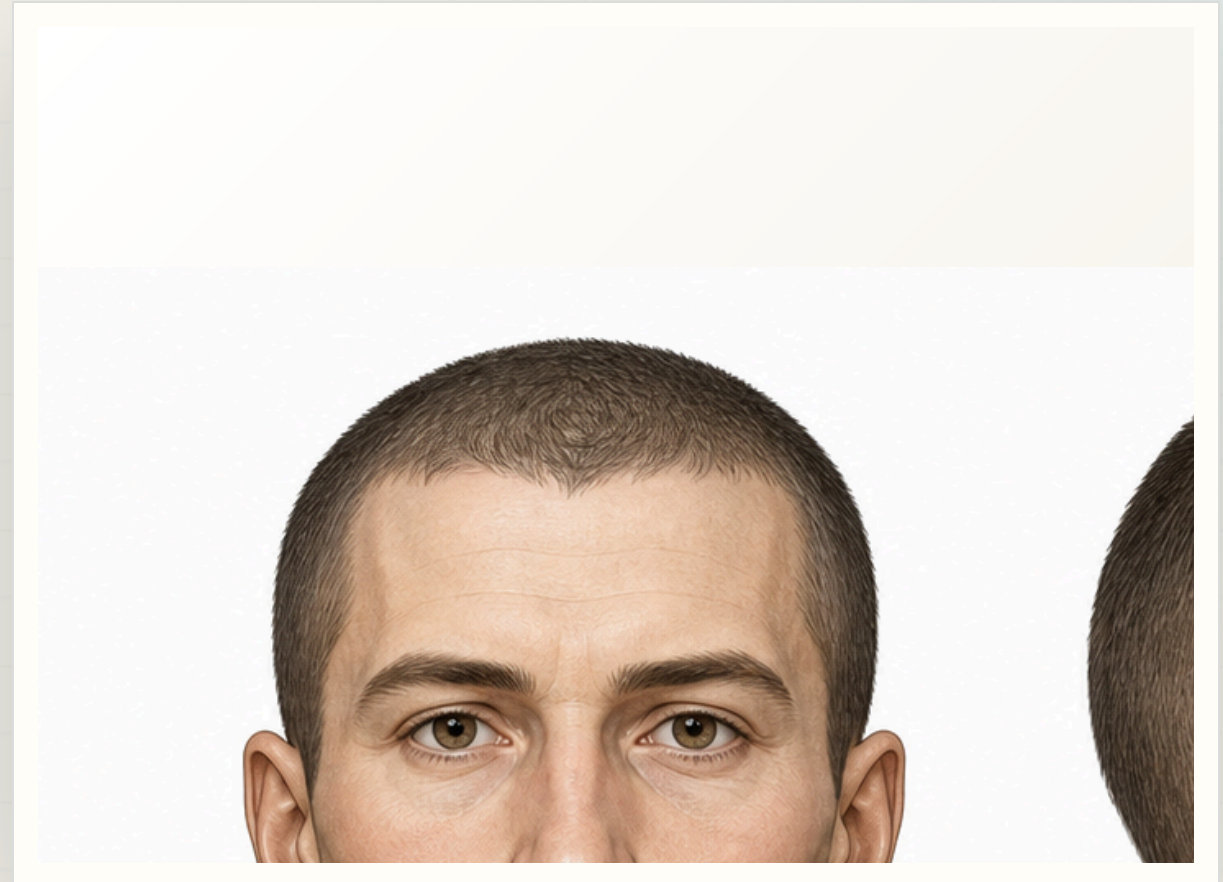
Depresión de la línea media inmediatamente inferior al occipucio, en la unión cráneo–cervical.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Debajo de la protuberancia occipital externa.
- Por encima de las primeras apófisis espinosas cervicales.
- En la línea media posterior.

RELACIÓN SUPERFICIAL Inserciones fasciales y musculares de la nuca sobre la unión cráneo–cervical.

PRECISIÓN No es la fosa suboccipital lateral situada detrás del mastoides.



PUNTO 05 • CABEZA

Fosa suboccipital

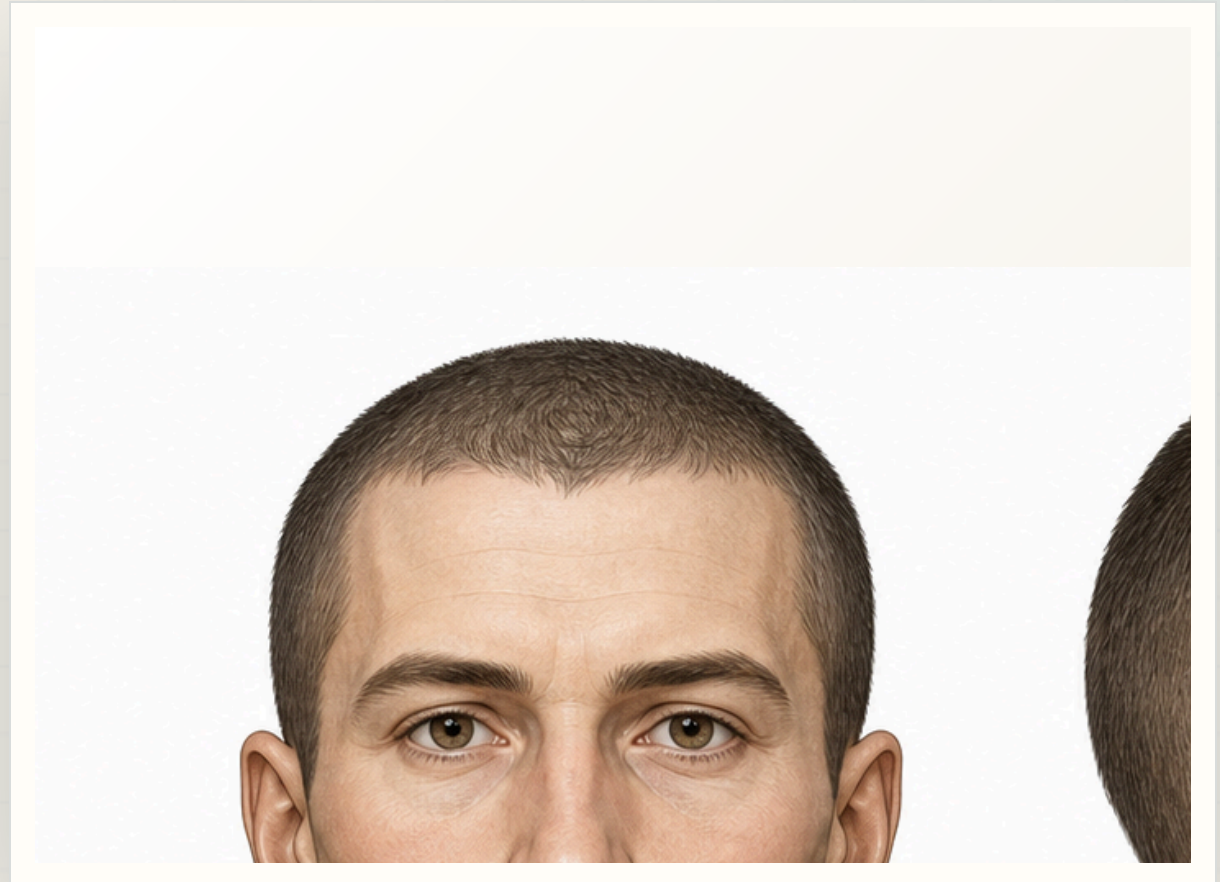
Depresión posterolateral de la base del cráneo, detrás del mastoides.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Entre el esternocleidomastoideo y el borde superior del trapecio.
- Inferior al occipital lateral.
- Referencia tradicional cercana a VB20.

RELACIÓN SUPERFICIAL Músculos suboccipitales y planos profundos de la base craneal.

PRECISIÓN La referencia es lateral y bilateral; no debe desplazarse a la línea media.



PUNTO 06 • CABEZA

Fosa retromandibular

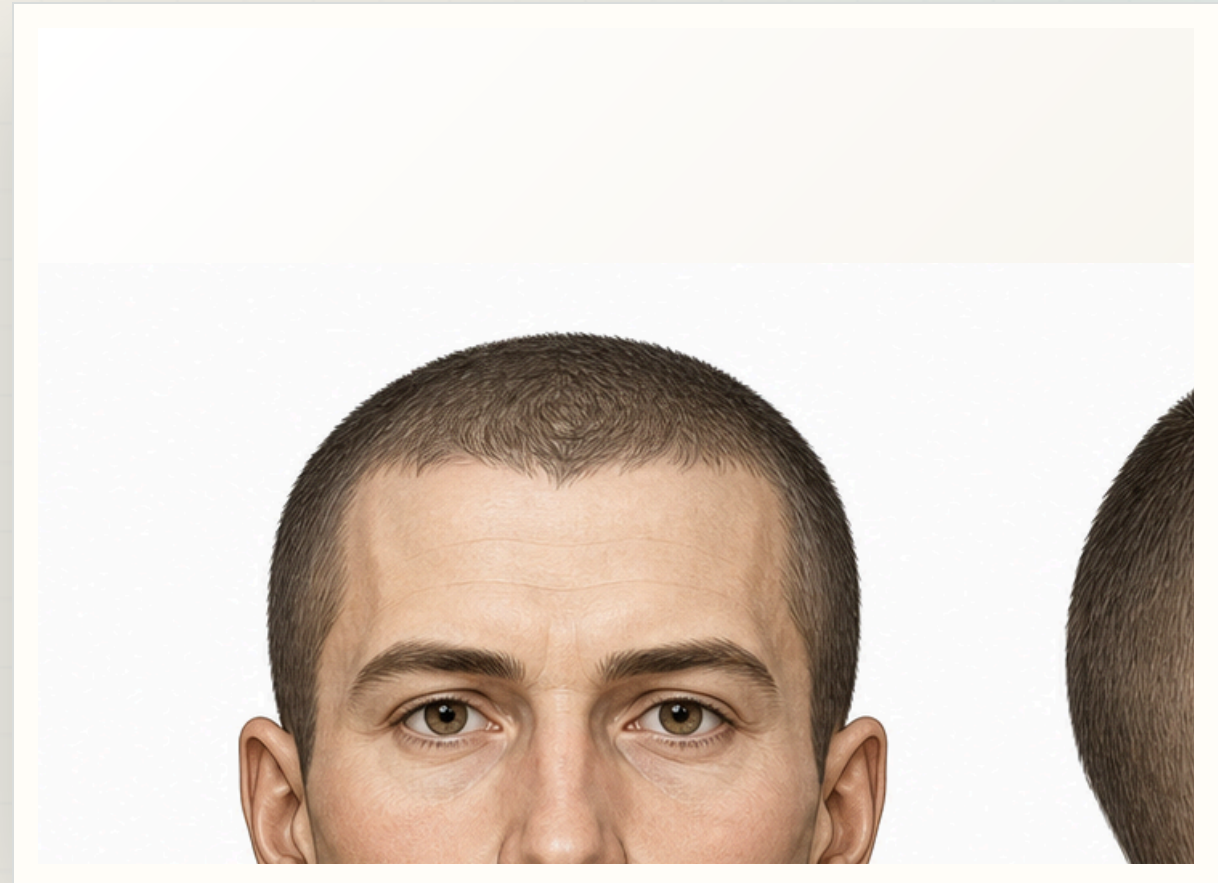
Depresión situada detrás de la rama mandibular y delante del mastoides.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Posterior al ángulo y a la rama de la mandíbula.
- Anterior al proceso mastoides.
- Inferior al pabellón auricular.

RELACIÓN SUPERFICIAL Región parotídea y retromandibular; pasan estructuras vasculares y nerviosas.

PRECISIÓN La palpación debe ser superficial; no se comprime la región parotídea.



PUNTO 07 • CABEZA

Área temporal

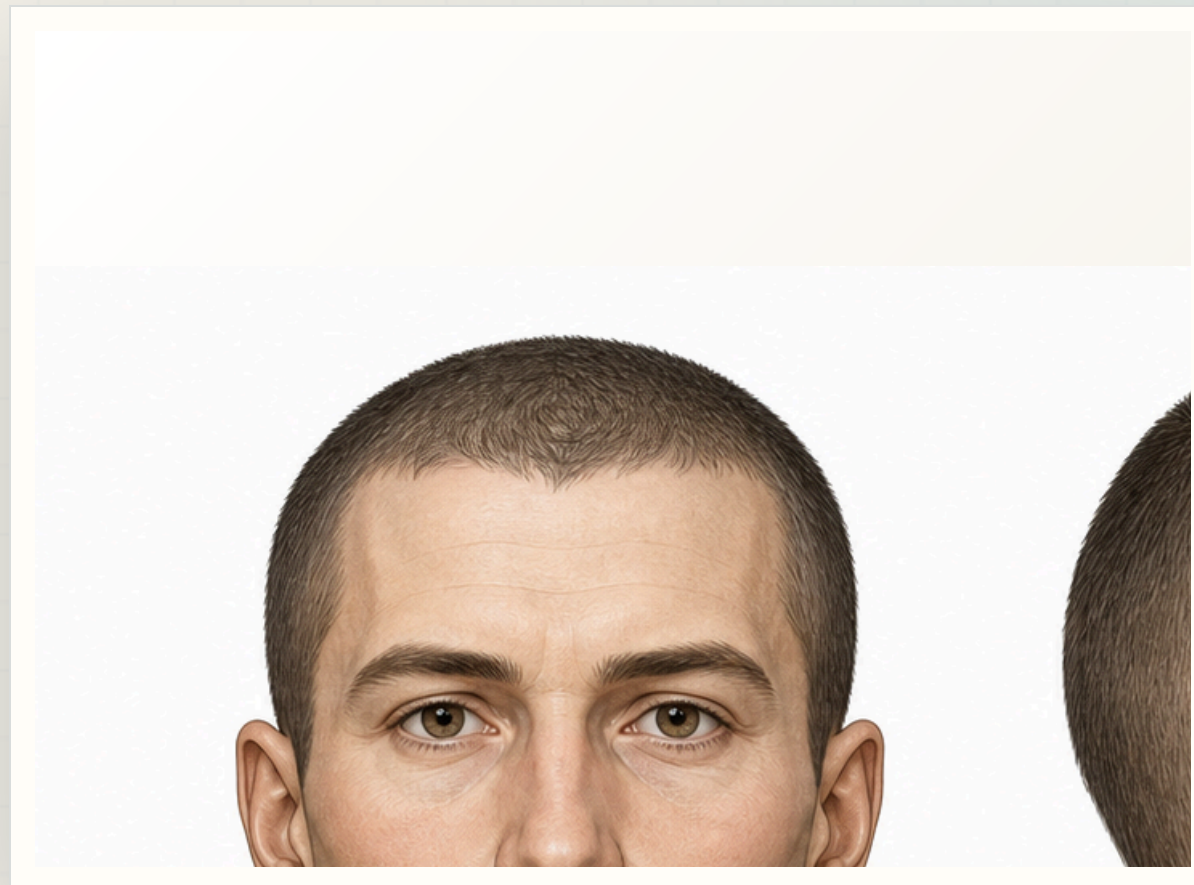
El método la ubica sobre el masetero, en la cara lateral de la mandíbula.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Arco cigomático por arriba.
- Rama mandibular por debajo.
- Masetero palpable al apretar suavemente los dientes.

RELACIÓN SUPERFICIAL Músculo masetero y fascia parotídeo-masetérica.

PRECISIÓN Terminología ambigua: la región temporal anatómica está por encima del arco cigomático; el dictado señala el masetero.



PUNTO 08 • CUELLO

Área paravertebral cervical

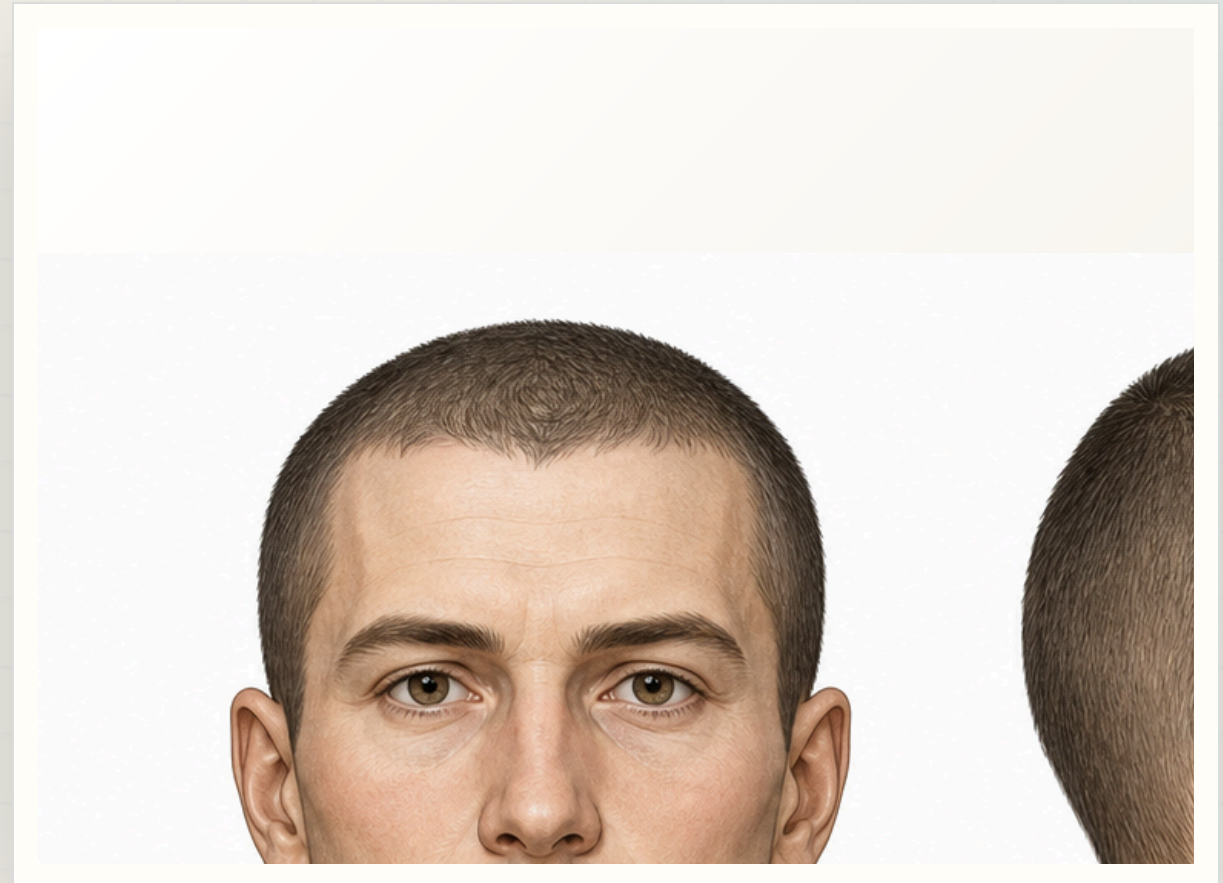
Columnas de tejido situadas a ambos lados de las apófisis espinosas cervicales.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Apófisis espinosa de C7 como referencia inferior.
- Línea media posterior del cuello.
- Surco muscular paravertebral derecho e izquierdo.

RELACIÓN SUPERFICIAL Músculos extensores cervicales y articulaciones posteriores profundas.

PRECISIÓN No corresponde a la cara anterolateral del cuello ni al trayecto carotídeo.



PUNTO 09 • CUELLO

Piel sobre el esternocleidomastoideo

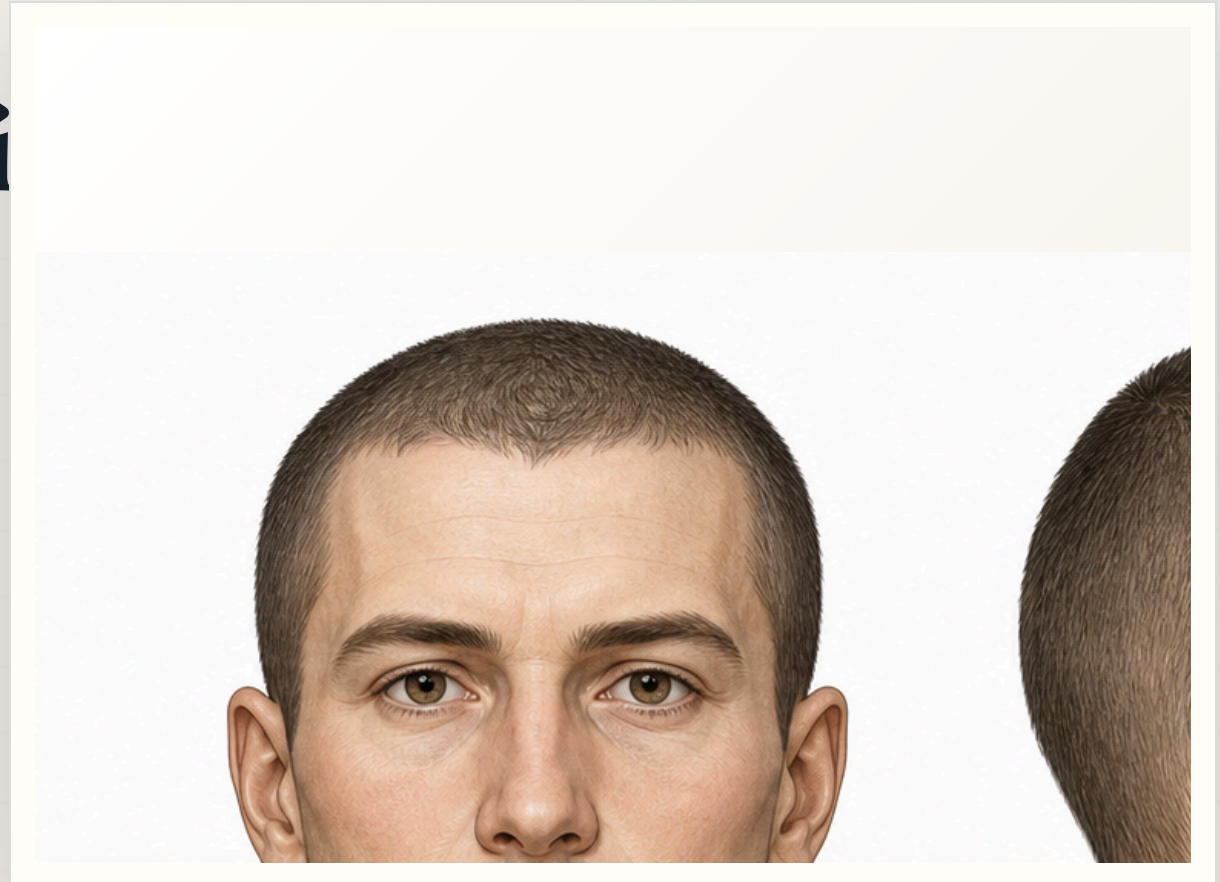
Superficie cutánea que sigue el relieve del músculo desde el mastoide hasta esternón y clavícula.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Mastoides por arriba.
- Manubrio esternal y tercio medial de clavícula por abajo.
- El músculo resalta al girar la cabeza al lado contrario.

RELACIÓN SUPERFICIAL Esternocleidomastoideo superficial; el paquete carotídeo queda profundo y medial.

PRECISIÓN Solo referencia superficial, sin presión profunda sobre el triángulo carotídeo.



PUNTO 10 • CUELLO

Fosa yugular

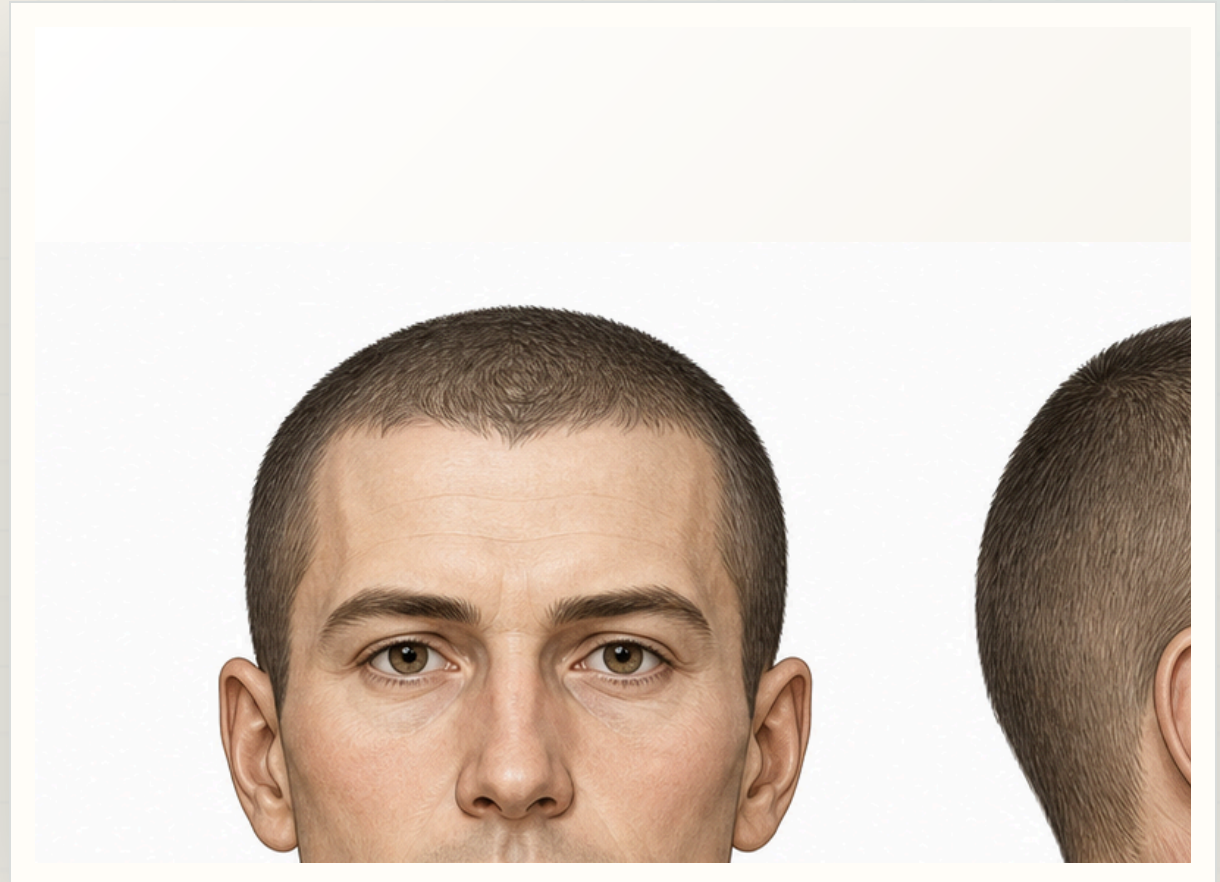
Escotadura media del borde superior del manubrio esternal.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Entre los extremos mediales de ambas clavículas.
- En la línea media anterior.
- Superior al manubrio del esternón.

RELACIÓN SUPERFICIAL Piel y fascia sobre la escotadura yugular; estructuras mediastínicas quedan profundas.

PRECISIÓN Se identifica por contacto ligero, sin hundir los dedos detrás del manubrio.



PUNTO 11 • CUELLO

Fosa supraclavicular

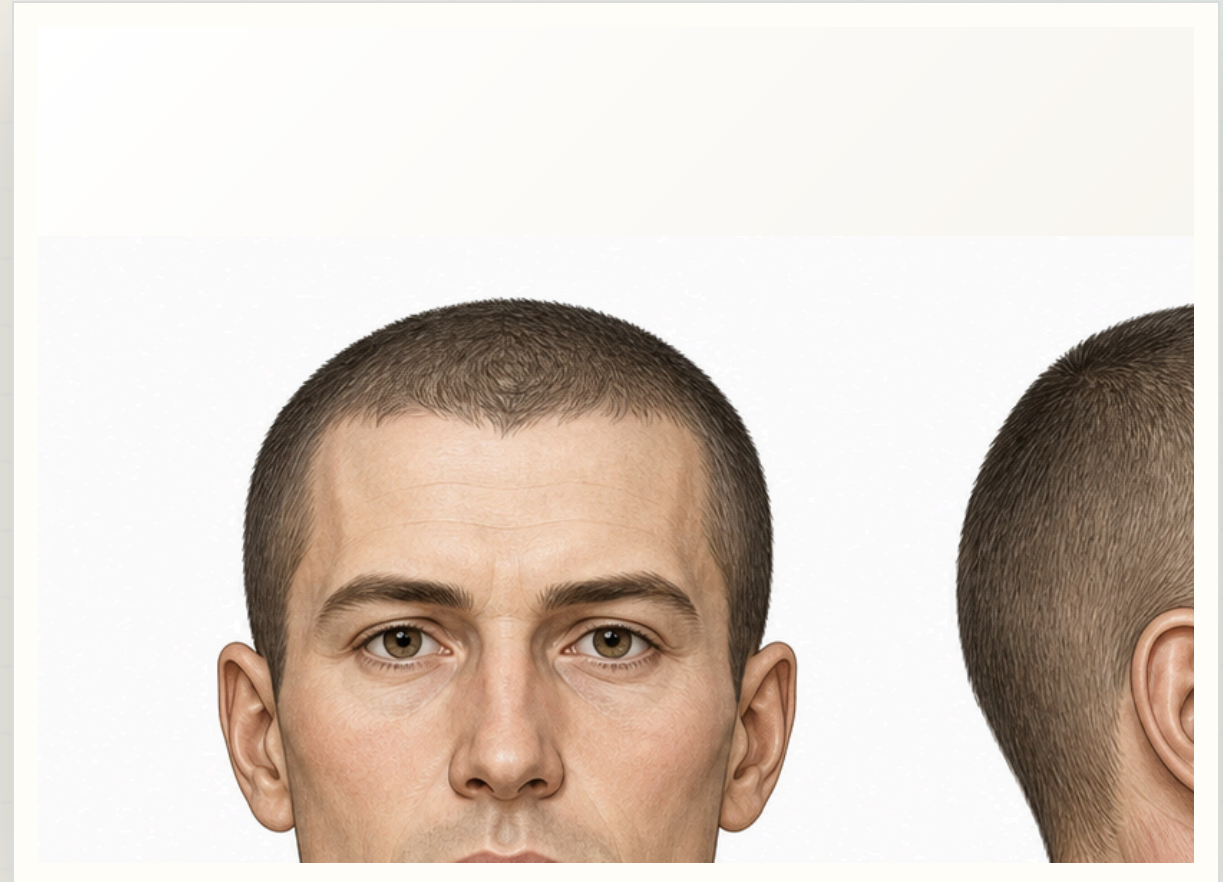
Depresión situada inmediatamente por encima de la clavícula y lateral al esternocleidomastoideo.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Clavícula como límite inferior.
- Borde posterior del esternocleidomastoideo como límite medial.
- Trapecio como límite posterolateral.

RELACIÓN SUPERFICIAL Techo del triángulo posterior; plexo braquial y vasos subclavios se encuentran profundos.

PRECISIÓN Zona neurovascular: contacto superficial y sin compresión sostenida.



PUNTO 12 • TÓRAX ANTERIOR

Área xifo-esternal

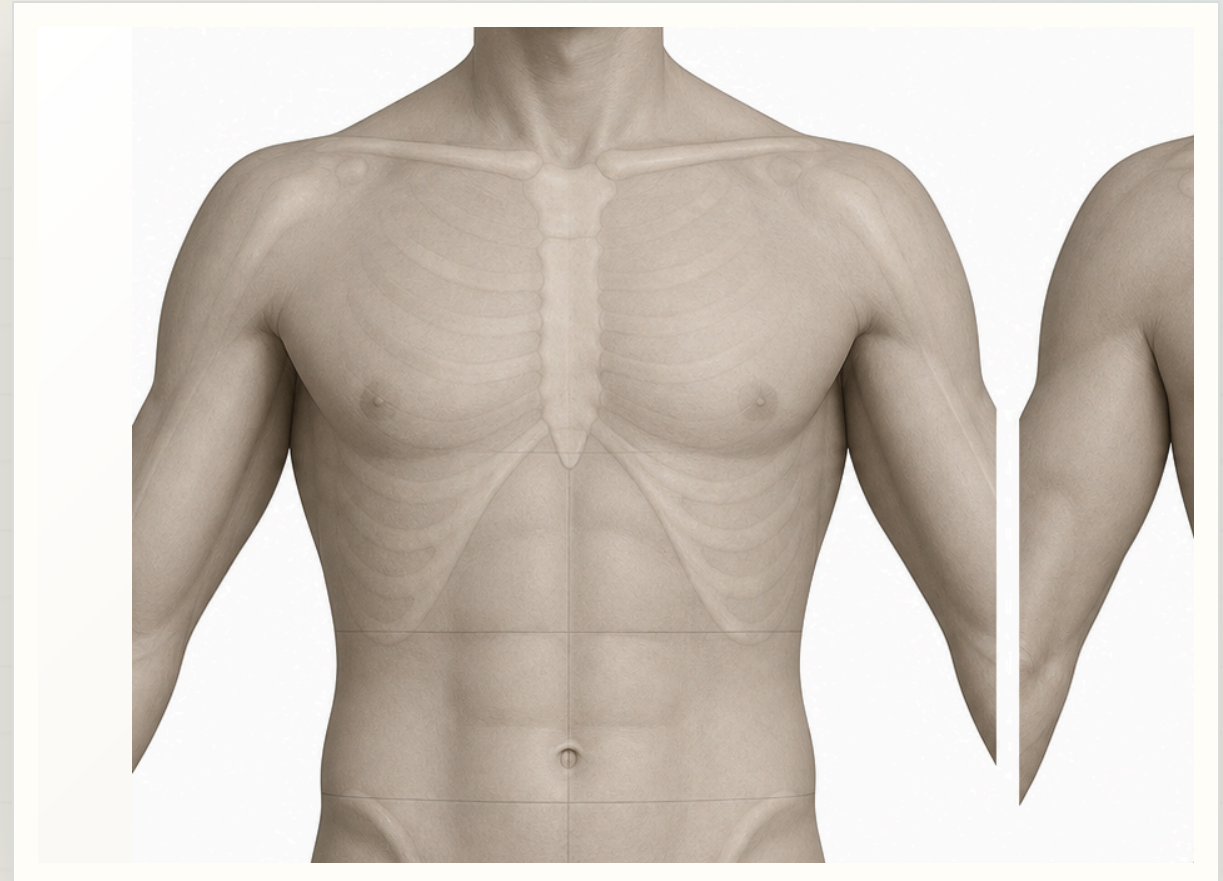
Unión entre el cuerpo del esternón y el proceso xifoides.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Línea media anterior.
- Extremo inferior del cuerpo esternal.
- Superior inmediato al epigastrio.

RELACIÓN SUPERFICIAL Articulación xifoesternal y pared torácica anterior.

PRECISIÓN El xifoides puede ser sensible y variable; no se ejerce presión fuerte.



PUNTO 13 • TÓRAX ANTERIOR

Triángulo deltopectoral

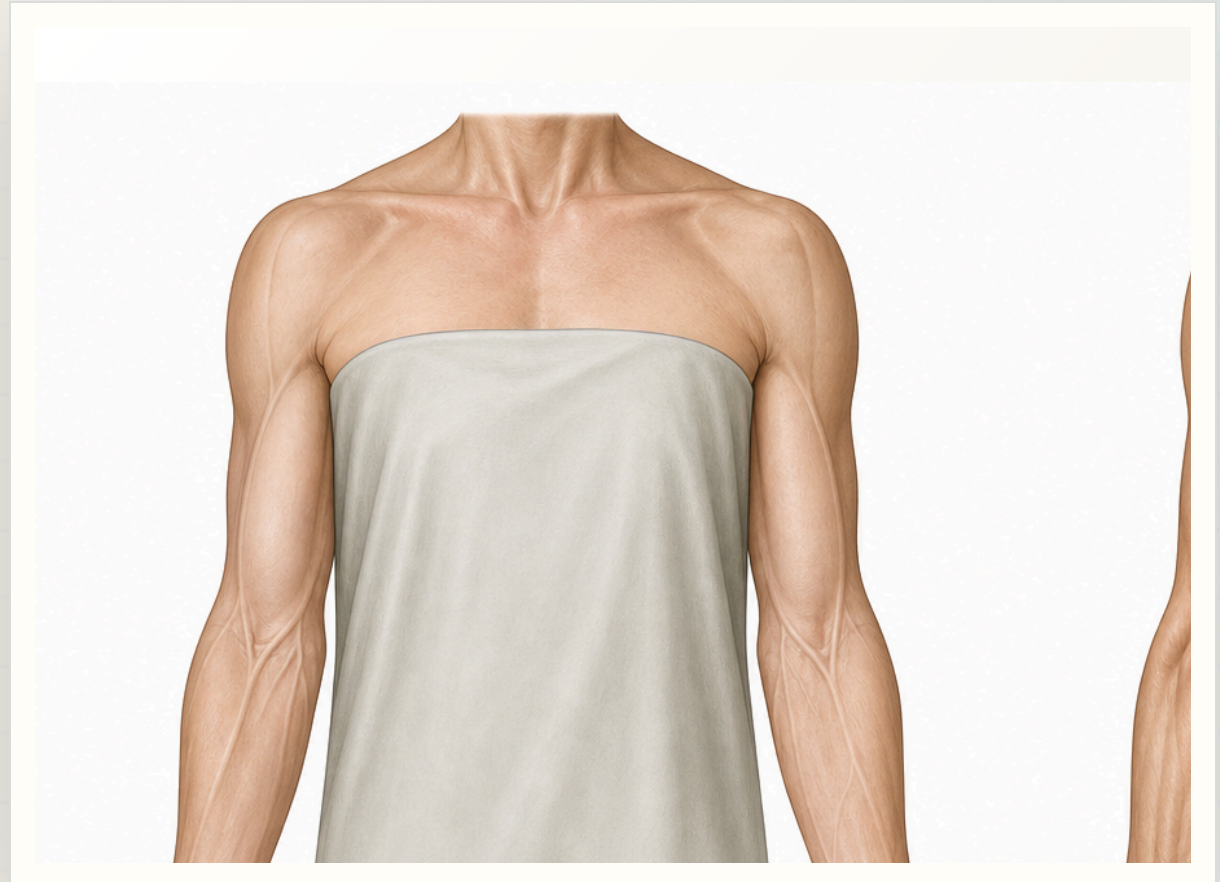
Depresión infraclavicular entre los bordes del deltoides y el pectoral mayor.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Clavícula por arriba.
- Deltoides lateralmente.
- Pectoral mayor medialmente.

RELACIÓN SUPERFICIAL Surco deltopectoral; la vena cefálica discurre en este intervalo.

PRECISIÓN Se marca la depresión superficial, sin comprimir estructuras vasculares.



PUNTO 14 • TÓRAX ANTERIOR

Área precordial

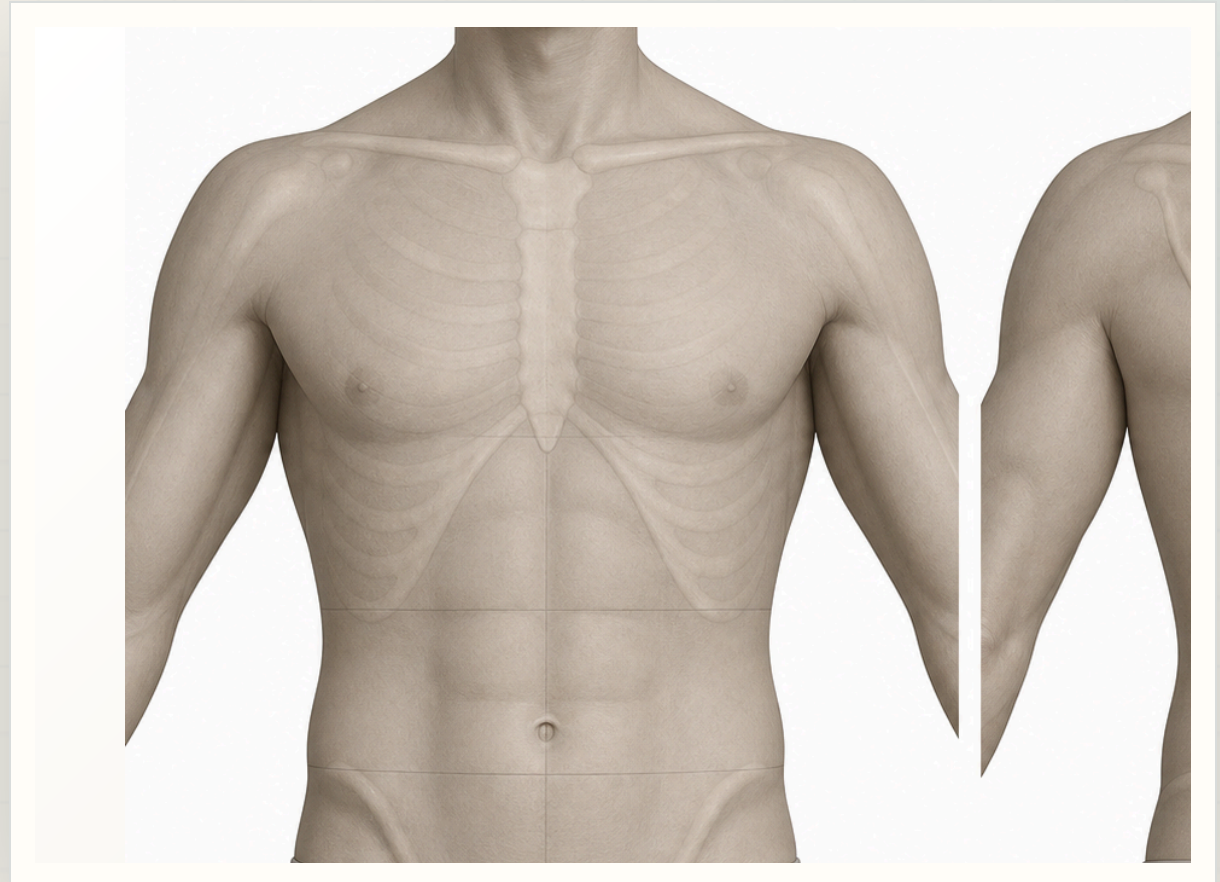
Región de la pared torácica anterior que se proyecta sobre el corazón, principalmente a la izquierda.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Borde esternal izquierdo.
- Línea medioclavicular izquierda.
- Espacios intercostales anteriores.

RELACIÓN SUPERFICIAL Piel, tejido subcutáneo, músculos pectorales y parrilla costal; el corazón está profundo.

PRECISIÓN Es una región, no un punto único. No equivale a localizar el ápex cardiaco sin exploración clínica.



PUNTO 15 • TRONCO POSTERIOR

Vértebras, una a una

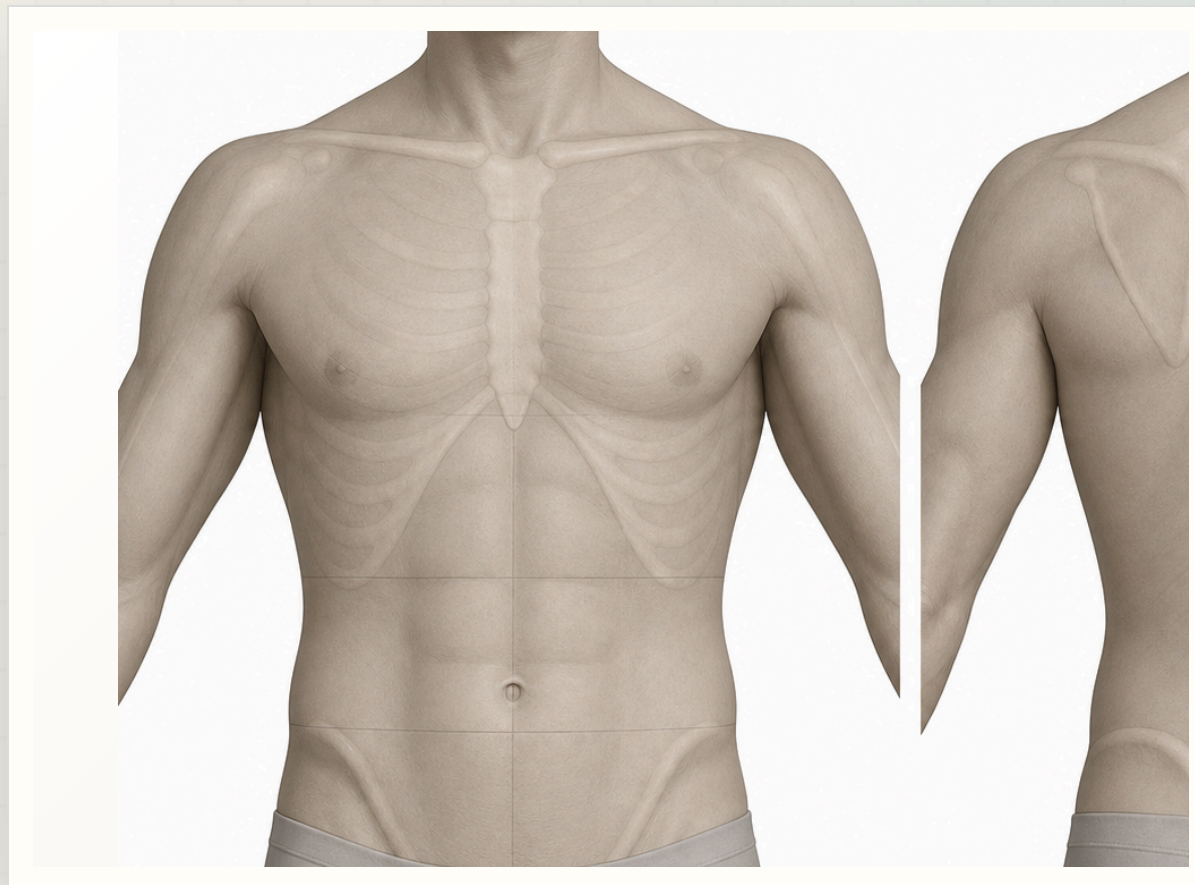
Apófisis espinosas palpables sobre la línea media desde la región cervical hasta el sacro.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- C7 suele ser la prominencia cervical más visible.
- Línea media de las apófisis espinosas.
- Sacro como referencia inferior del recorrido.

RELACIÓN SUPERFICIAL Piel, ligamentos supraespinosos y apófisis espinosas.

PRECISIÓN El protocolo exige niveles individuales; no se sustituye por un barrido general de la espalda.



PUNTO 16 • TRONCO POSTERIOR

Región paravertebral

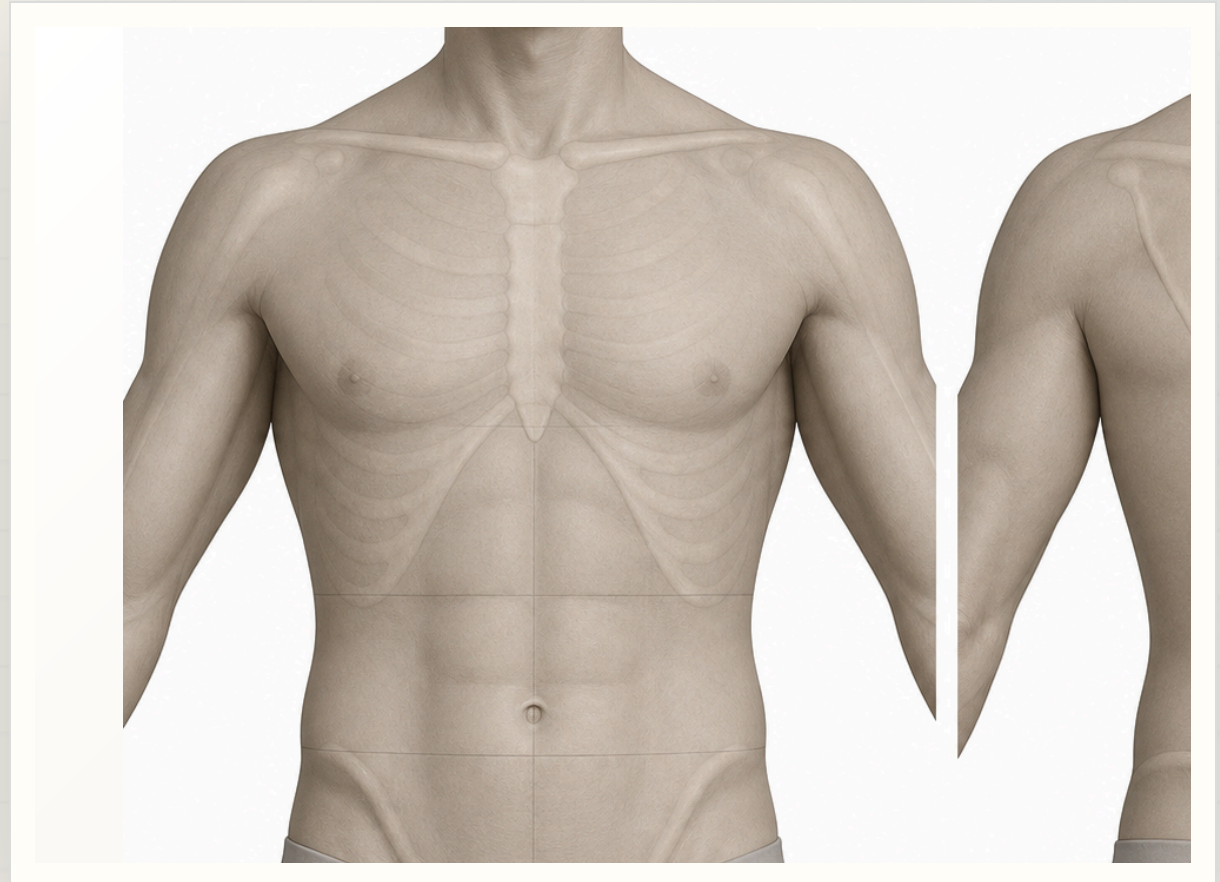
Bandas musculares longitudinales a derecha e izquierda de cada nivel vertebral.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Apófisis espinosa como referencia medial.
- Masa de los erectores espinales.
- Recorrido paralelo desde cuello hasta región lumbar.

RELACIÓN SUPERFICIAL Musculatura epaxial; articulaciones y raíces nerviosas se encuentran profundas.

PRECISIÓN Se registra por nivel y por lado; no es una sola zona extensa.



PUNTO 17 • TRONCO POSTERIOR

Borde superior del trapecio

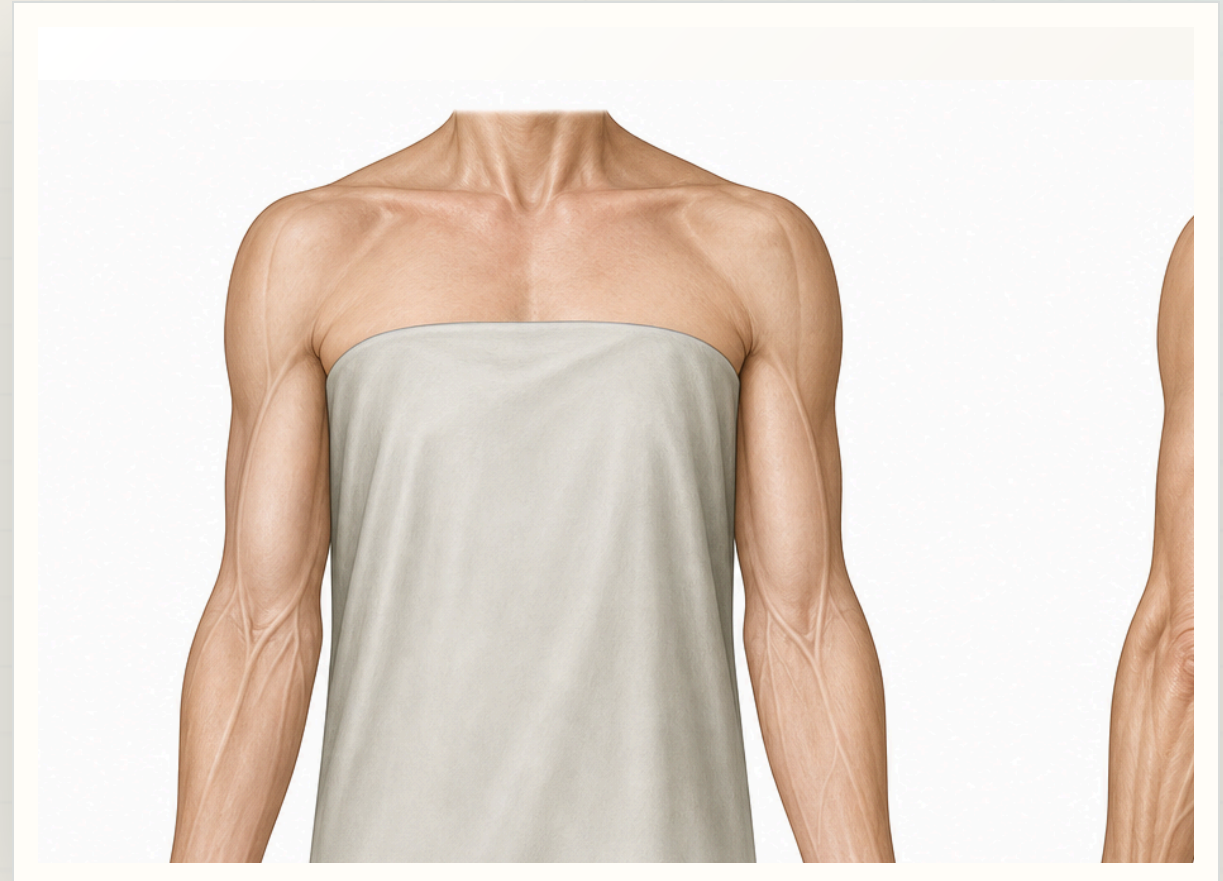
Relieve muscular que une la región cervical lateral con el hombro.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Acromion lateralmente.
- Base del cuello medialmente.
- Fibras superiores del trapecio entre ambos puntos.

RELACIÓN SUPERFICIAL Trapecio superficial; el plexo braquial se encuentra más anterior e inferior.

PRECISIÓN No desplazar la localización a la fosa supraclavicular.



PUNTO 18 • TRONCO POSTERIOR

Borde vertebral de la escápula

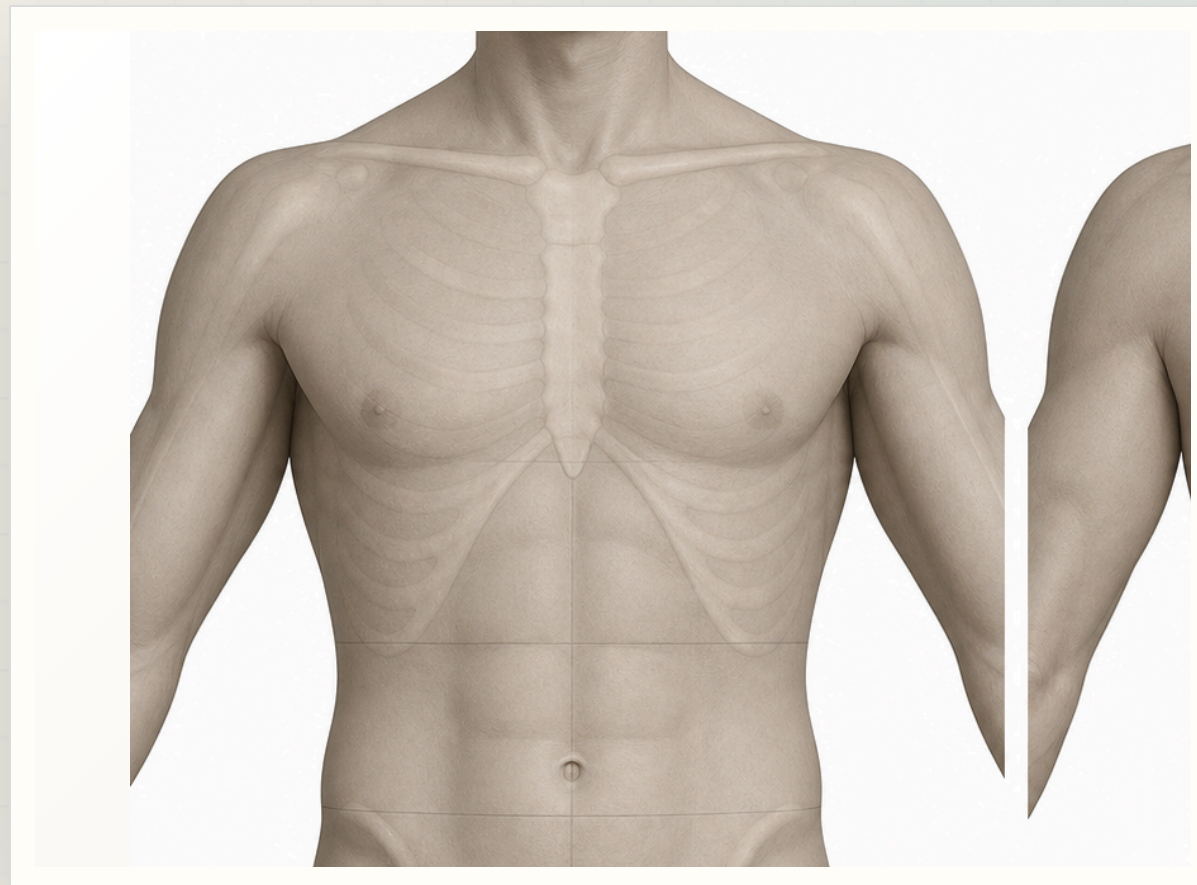
Borde medial de la escápula, el más próximo a la columna.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Raíz de la espina escapular por arriba.
- Ángulo inferior por abajo.
- Columna vertebral medial a la escápula.

RELACIÓN SUPERFICIAL Trapecio y romboides cubren o se insertan en el borde medial.

PRECISIÓN El documento lo llama también “borde lateral” en un fragmento oral; la versión consolidada fija borde vertebral.



PUNTO 19 • ABDOMEN

Zona epigástrica

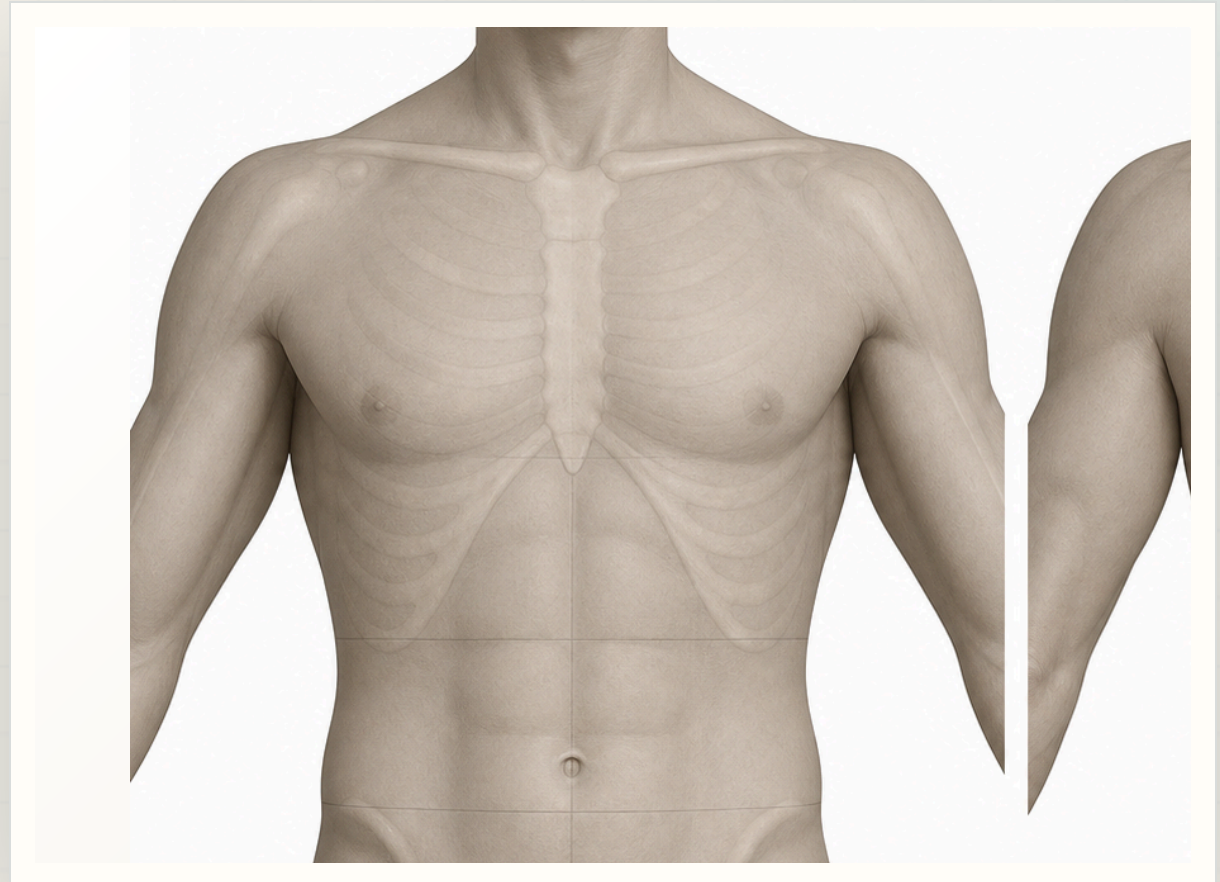
Región superior y central del abdomen, inmediatamente inferior al xifoides.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Márgenes costales derecho e izquierdo.
- Xifoides por arriba.
- Región umbilical por abajo.

RELACIÓN SUPERFICIAL Pared abdominal sobre estómago, hígado izquierdo y otras vísceras profundas; no identifica un órgano específico.

PRECISIÓN La proyección visceral cambia con respiración, llenado y constitución corporal.



PUNTO 20 • ABDOMEN

Zona mesogástrica

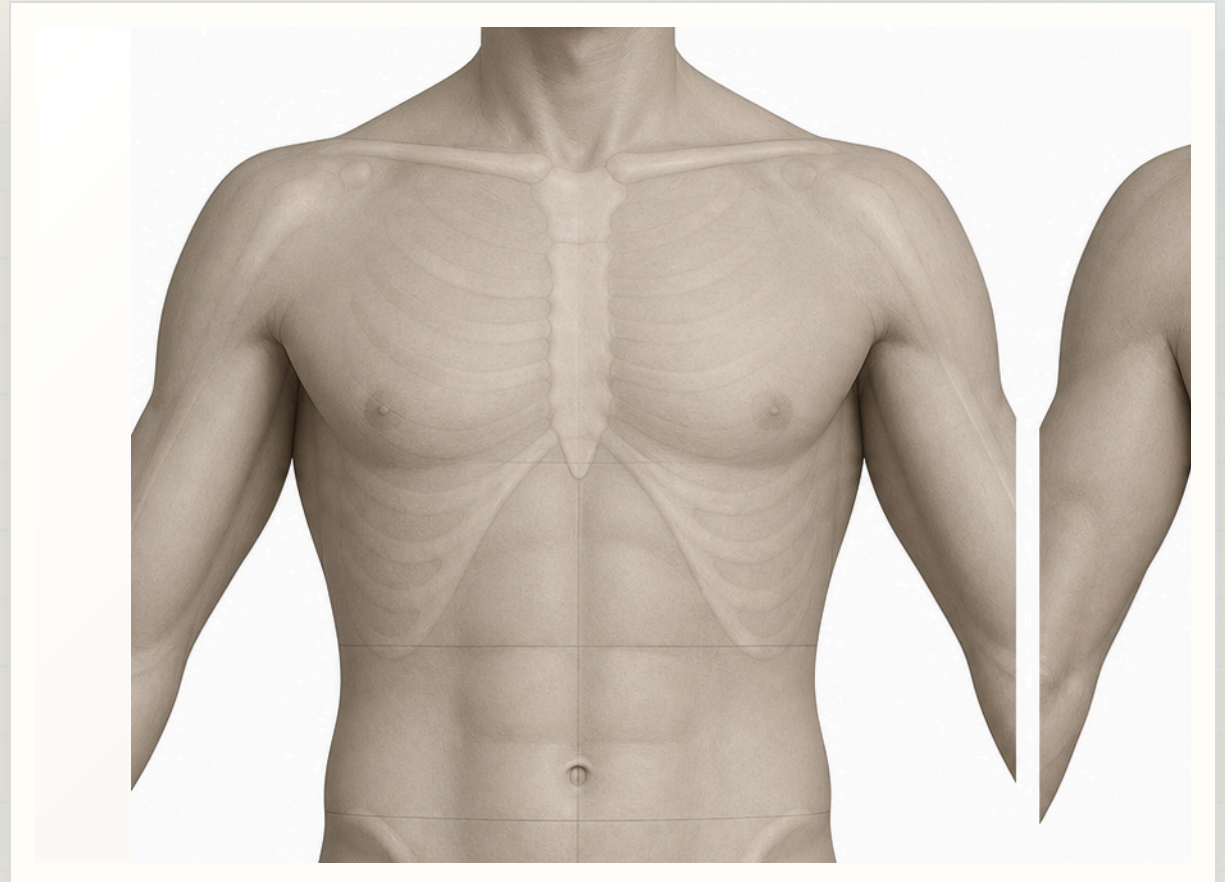
Región central del abdomen alrededor del plano umbilical.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Entre epigastrio e hipogastrio.
- Medial a las regiones laterales.
- Ombligo como referencia aproximada.

RELACIÓN SUPERFICIAL Pared abdominal anterior sobre asas intestinales variables.

PRECISIÓN "Mesogástrica" se usa aquí como región central; no es un punto aislado.



PUNTO 21 • ABDOMEN

Zona hipogástrica

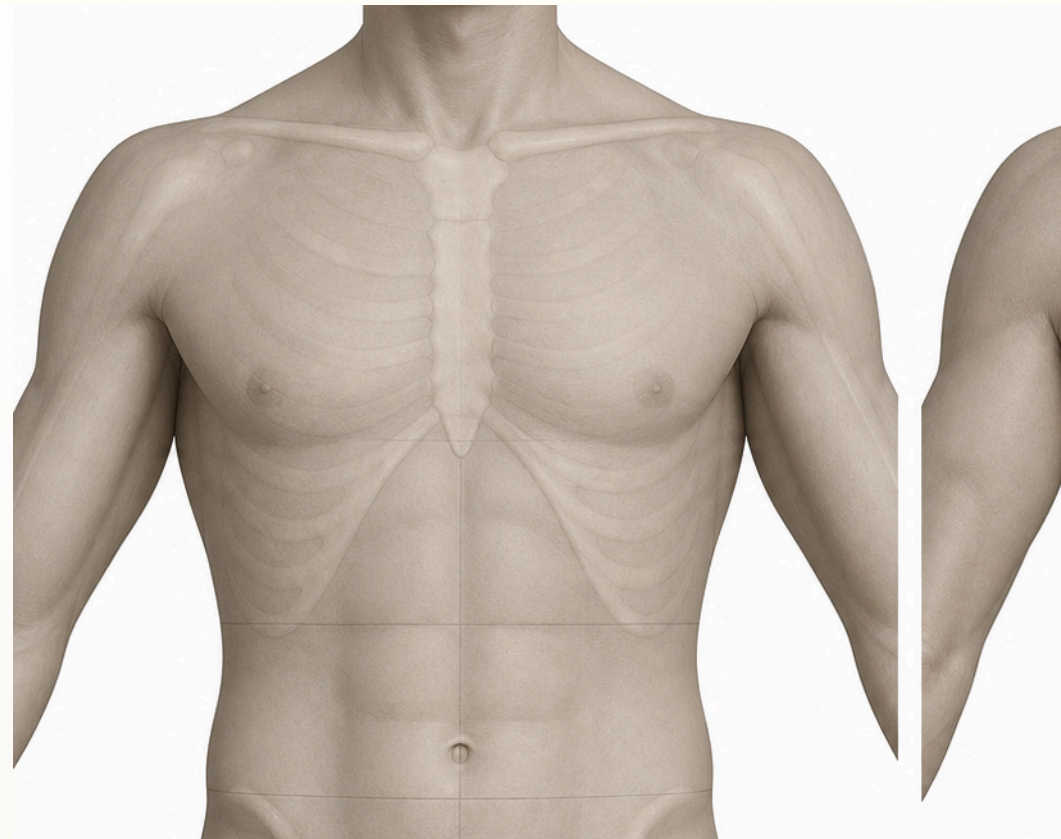
Región inferior y central del abdomen, por debajo de la región umbilical.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Sínfisis púbica por abajo.
- Ombligo por arriba.
- Fosas ilíacas a ambos lados.

RELACIÓN SUPERFICIAL Pared abdominal sobre vejiga y vísceras pélvicas variables.

PRECISIÓN No se identifica una víscera concreta y se respeta comodidad y privacidad.



PUNTO 22 • ABDOMEN

Ombligo

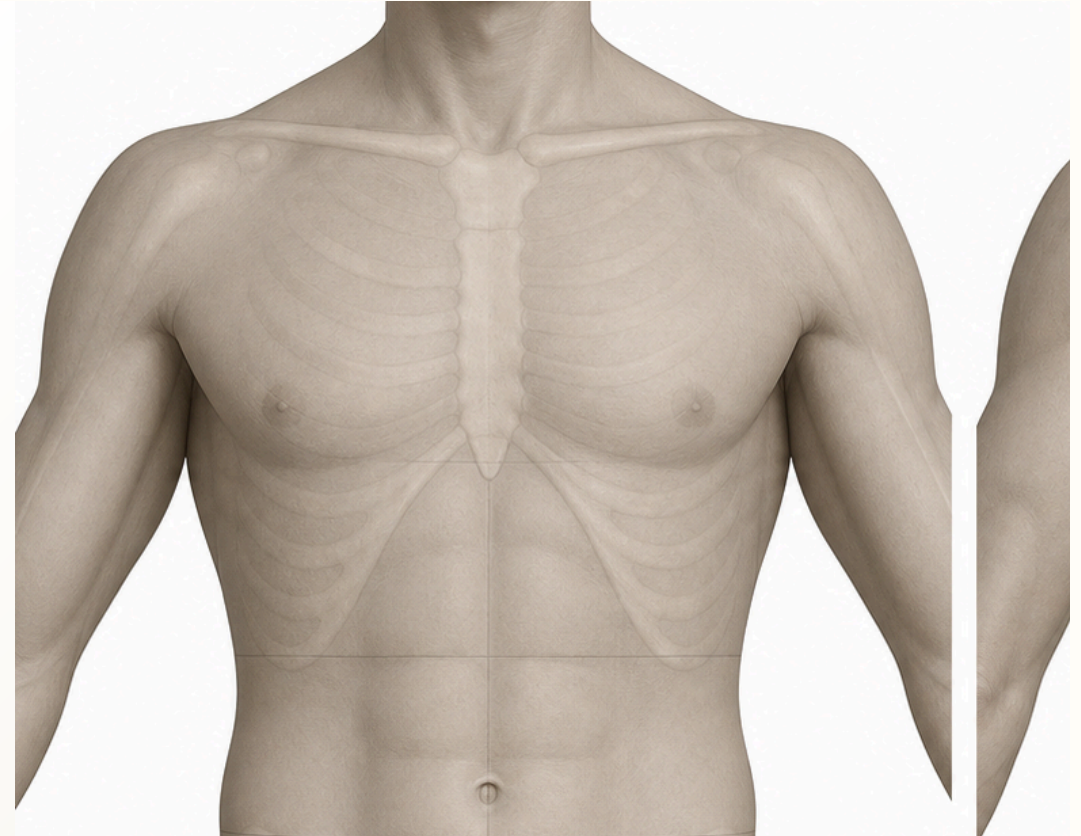
Cicatriz cutánea central de la pared abdominal anterior.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Referencia visible de la línea media.
- Centro aproximado de la región umbilical.
- Plano transumbilical variable entre personas.

RELACIÓN SUPERFICIAL Cicatriz umbilical y anillo fibroso de la pared abdominal.

PRECISIÓN Su altura cambia con edad, postura y constitución; no fija por sí solo un nivel vertebral exacto.



PUNTO 23 • ABDOMEN

Fosa ilíaca

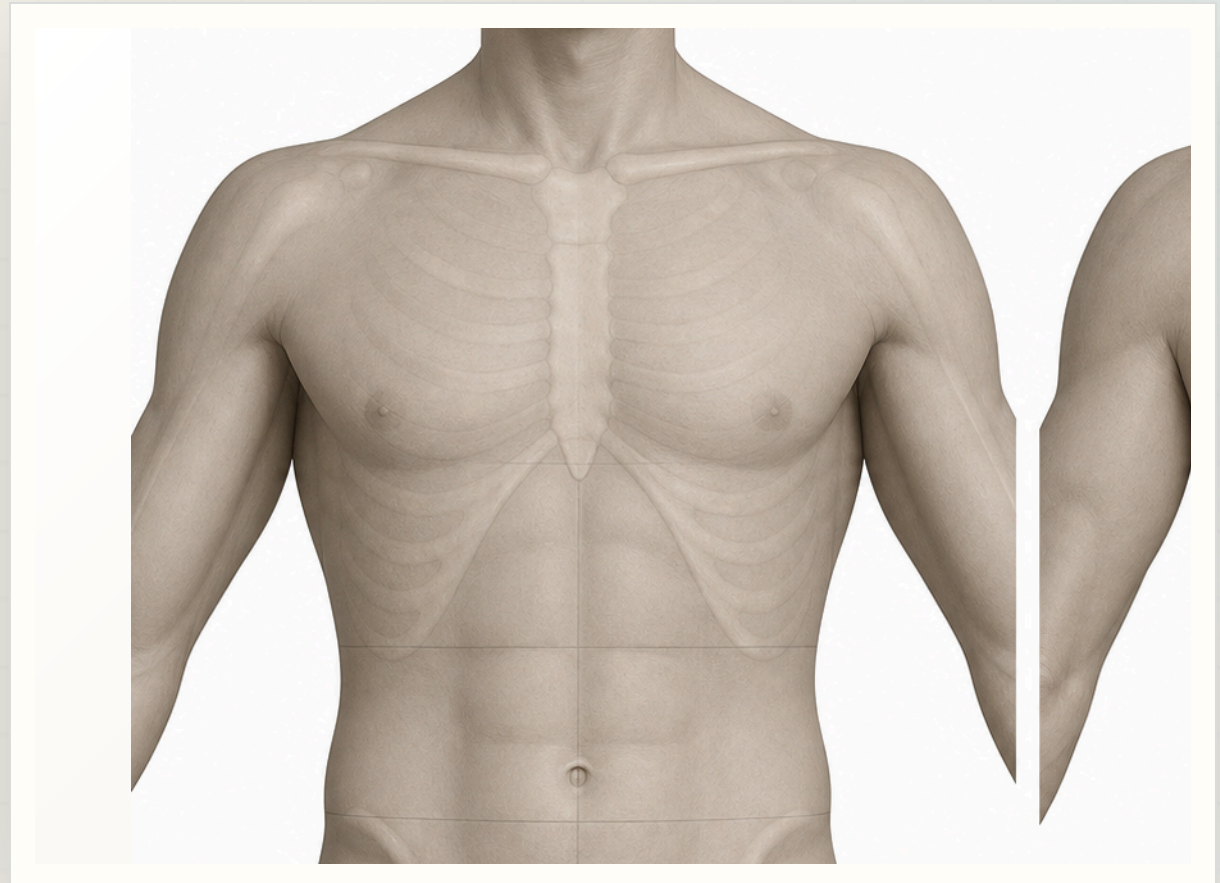
Región inferior y lateral del abdomen, a cada lado del hipogastrio.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Espina ilíaca ántero-superior lateralmente.
- Ligamento inguinal por abajo.
- Región umbilical superior y medial.

RELACIÓN SUPERFICIAL Pared abdominal sobre ciego a la derecha y colon sigmoide a la izquierda, con gran variabilidad.

PRECISIÓN Se localiza por referencias superficiales; no se realiza palpación abdominal diagnóstica.



PUNTO 24 • ABDOMEN

Región subcostal en los flancos

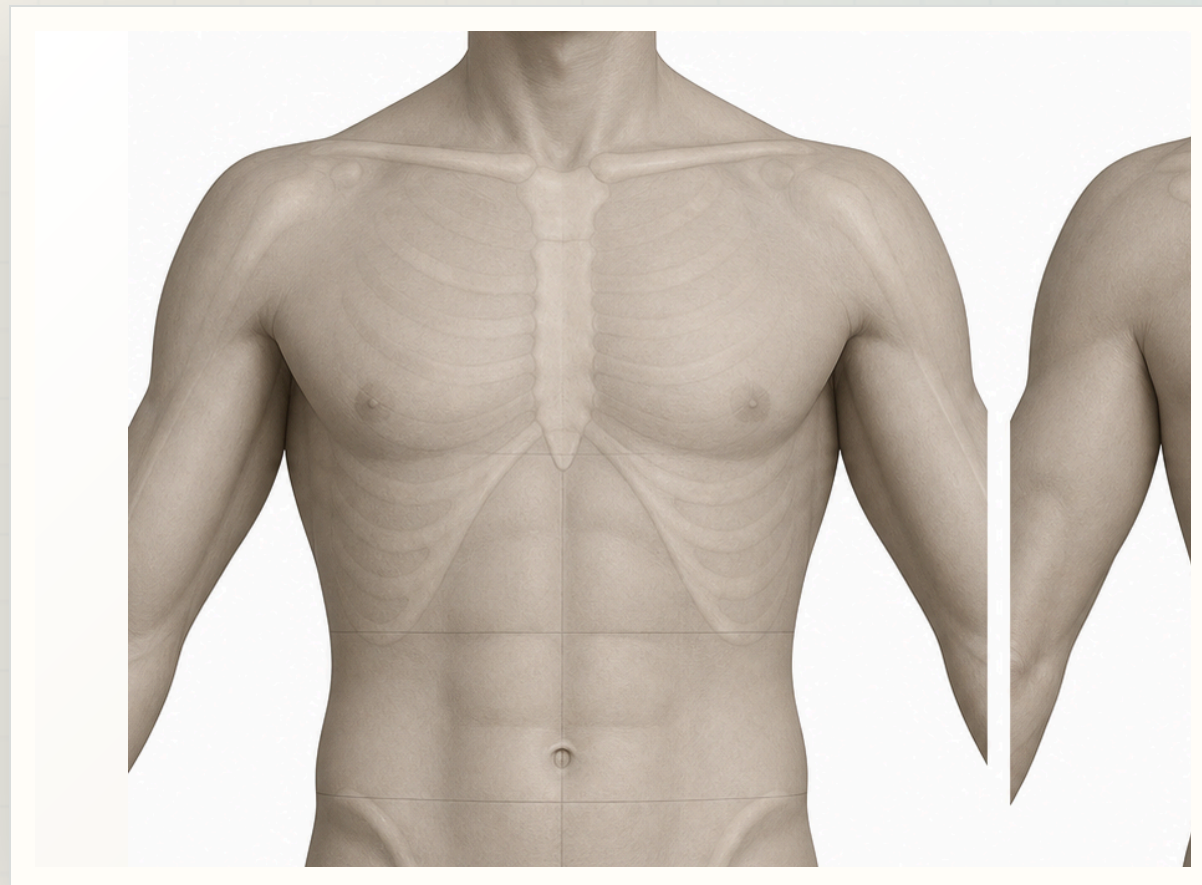
Zona lateral situada inmediatamente debajo del margen costal, hacia los extremos del tronco.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Borde inferior de las últimas costillas.
- Línea axilar media.
- Flanco derecho e izquierdo.

RELACIÓN SUPERFICIAL Pared abdominal lateral; costillas 10–12 y vísceras profundas variables.

PRECISIÓN El dictado señala “la parte más extrema”; hace falta fijar una distancia reproducible respecto del margen costal.



PUNTO 25 • PELVIS Y CADERA

Espina ilíaca pósterio-superior

Prominencia posterior del ilion situada a ambos lados del sacro.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

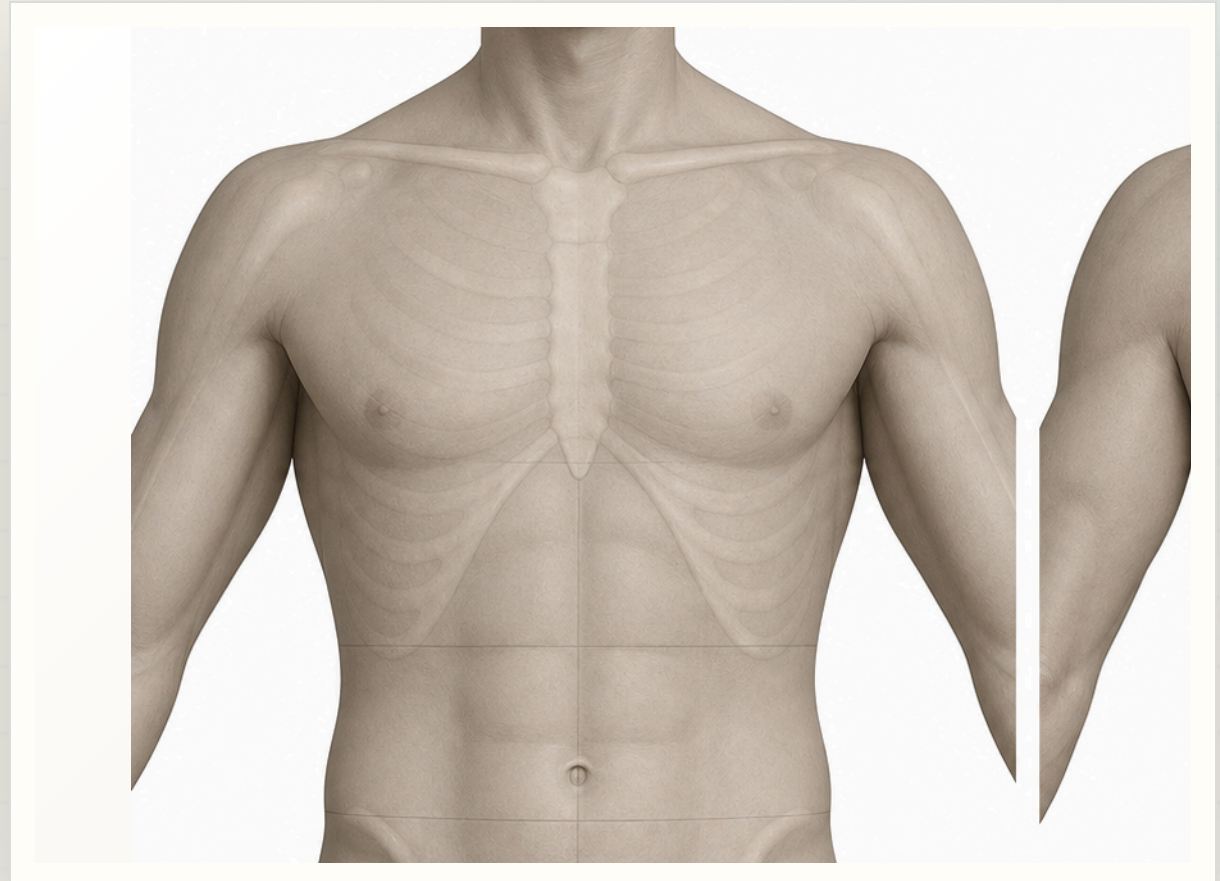
- Hoyuelos cutáneos lumbares cuando están presentes.
- Cresta ilíaca superior.
- Sacro medialmente.

RELACIÓN SUPERFICIAL

Inserciones ligamentarias y fascia toracolumbar sobre la articulación sacroilíaca.

PRECISIÓN

Los hoyuelos son orientativos; se confirma el relieve óseo con palpación suave.



PUNTO 26 • PELVIS Y CADERA

Espina ilíaca ántero-superior

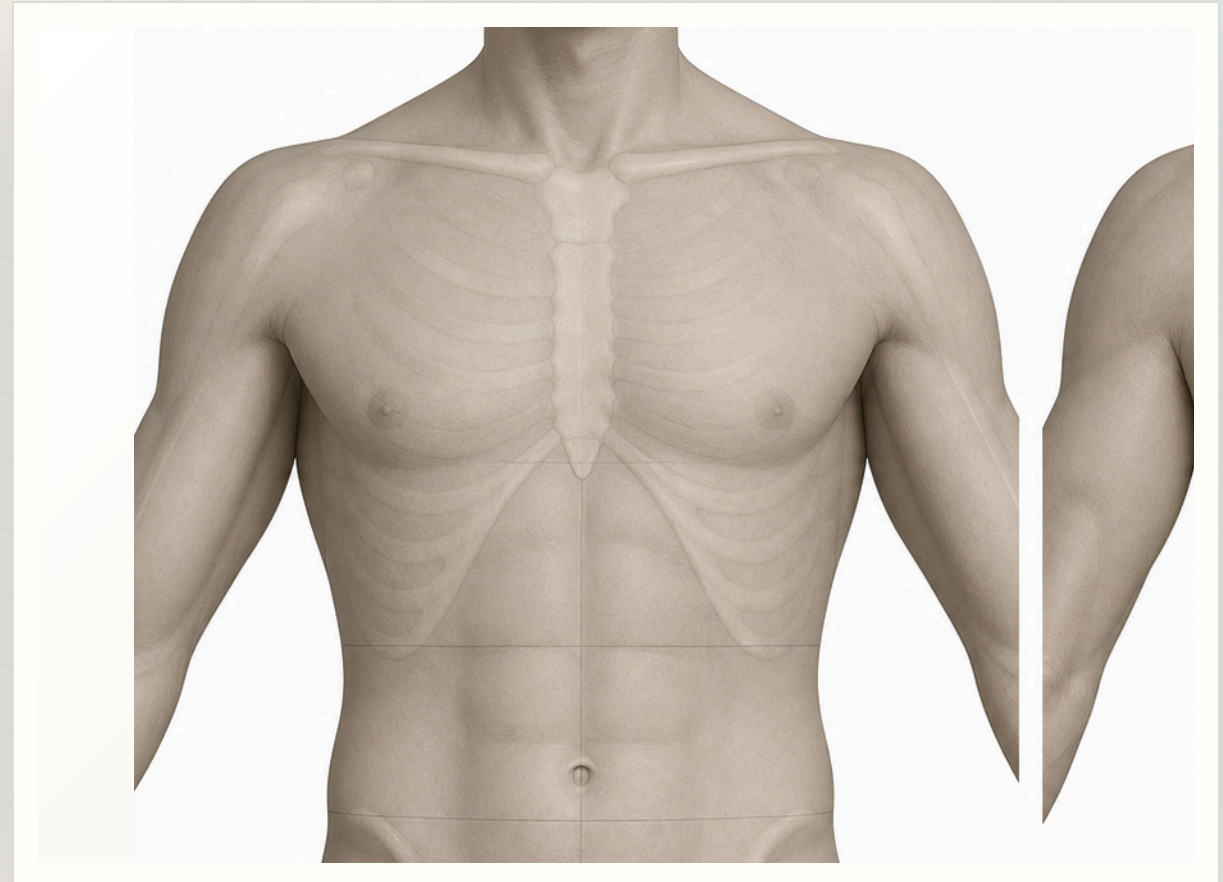
Extremo anterior palpable de la cresta ilíaca.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Cresta ilíaca hacia posterior.
- Ligamento inguinal hacia medial e inferior.
- Prominencia ósea anterior de la pelvis.

RELACIÓN SUPERFICIAL Origen del sartorio y fijación del ligamento inguinal.

PRECISIÓN La posición cambia con rotación pélvica; compare ambos lados en la misma postura.



PUNTO 27 • PELVIS Y CADERA

Región inguinal

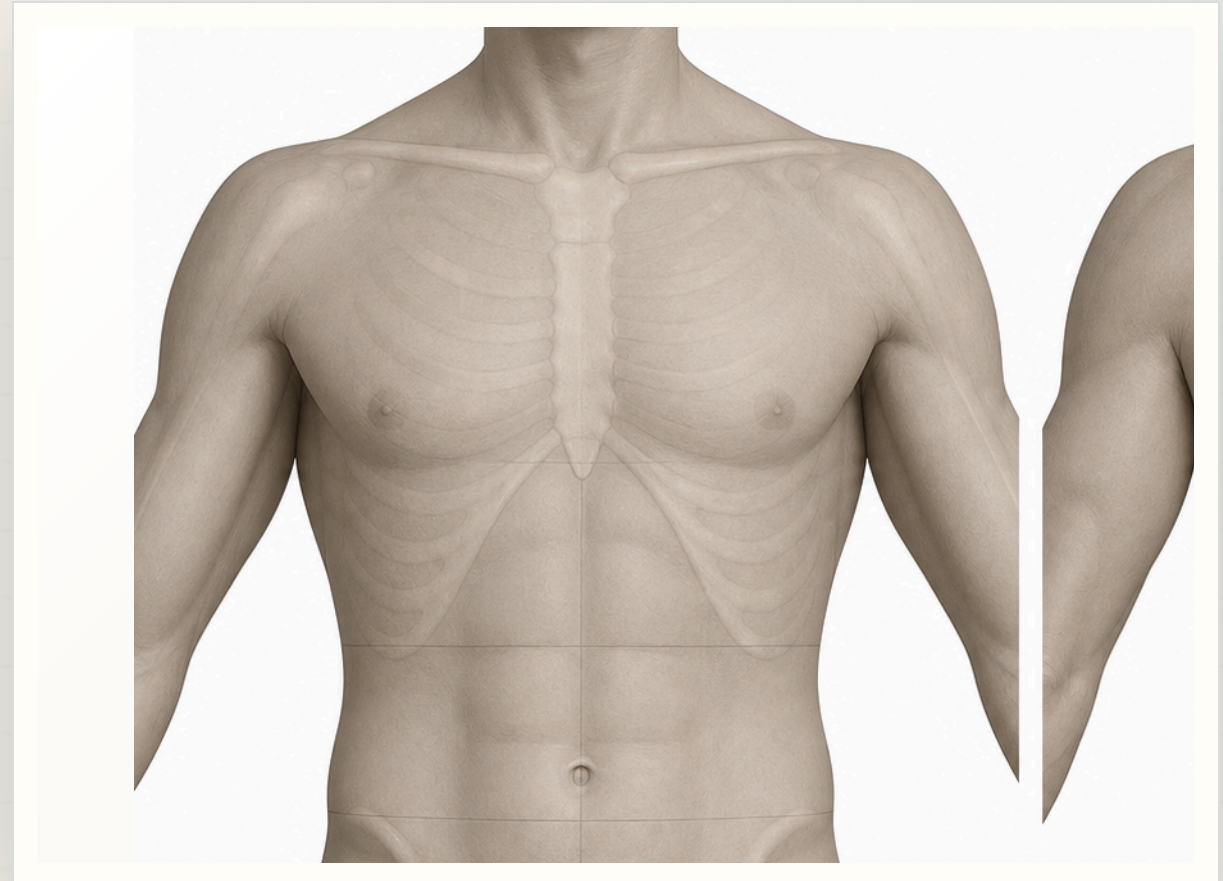
Pliegue oblicuo entre la espina ilíaca
ántero-superior y la región púbica.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- EIAS lateralmente.
- Tubérculo púbico medialmente.
- Pliegue inguinal superficial.

RELACIÓN SUPERFICIAL Ligamento inguinal; vasos y nervio femoral
pasan profundos en la región.

PRECISIÓN Zona neurovascular e íntima:
consentimiento, cobertura adecuada y
contacto superficial.



PUNTO 28 • PELVIS Y CADERA

Fosa trocantérea

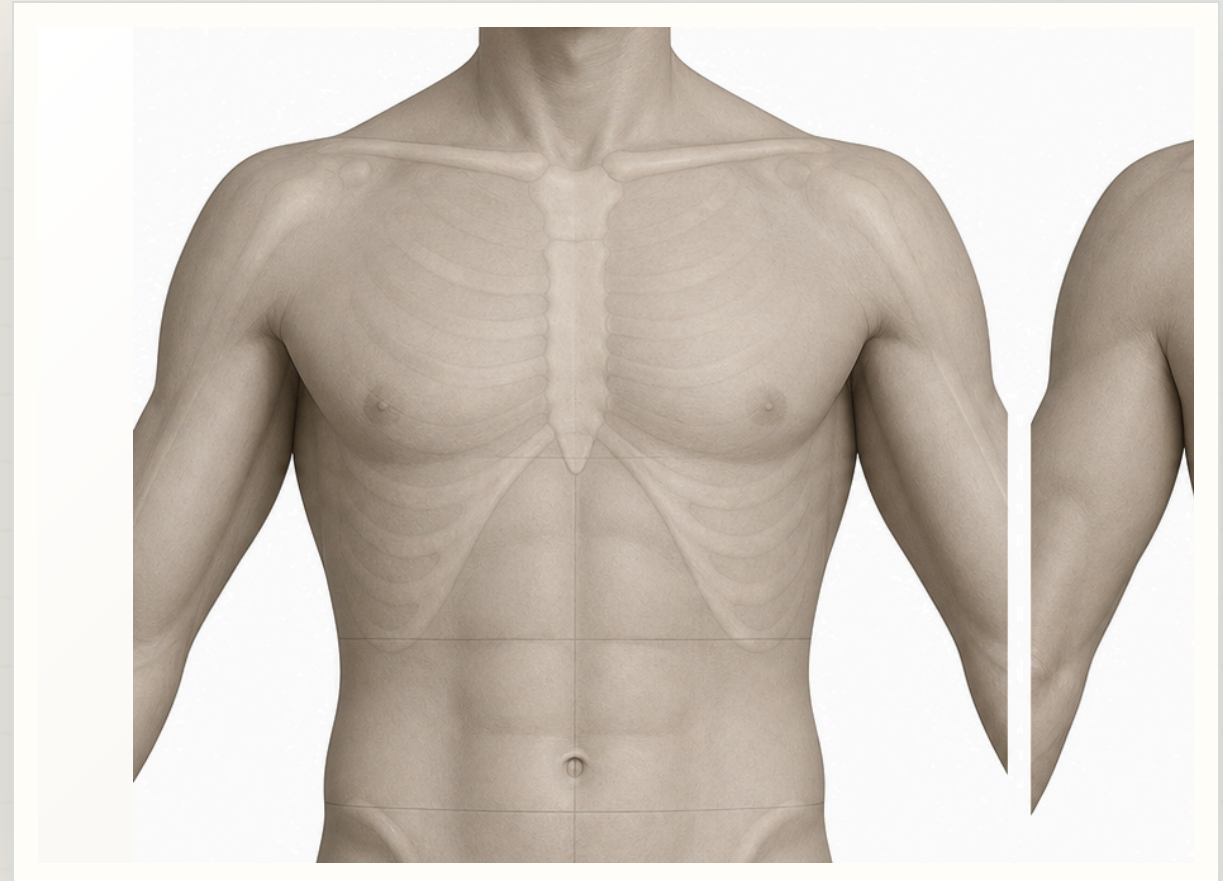
El dictado la sitúa en la depresión lateral del glúteo, sobre la región del trocánter mayor.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Trocánter mayor palpable en la cara lateral de la cadera.
- EIAS por delante.
- Pliegue glúteo por debajo y posterior.

RELACIÓN SUPERFICIAL Piel y músculos glúteos sobre el trocánter mayor.

PRECISIÓN Ambigüedad anatómica: la fosa trocantérea verdadera está en la cara medial del trocánter y no es palpable desde la superficie.



PUNTO 29 • PELVIS Y CADERA

Periné

Región romboidal inferior de la pelvis, entre pubis, tuberosidades isquiáticas y cóccix.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

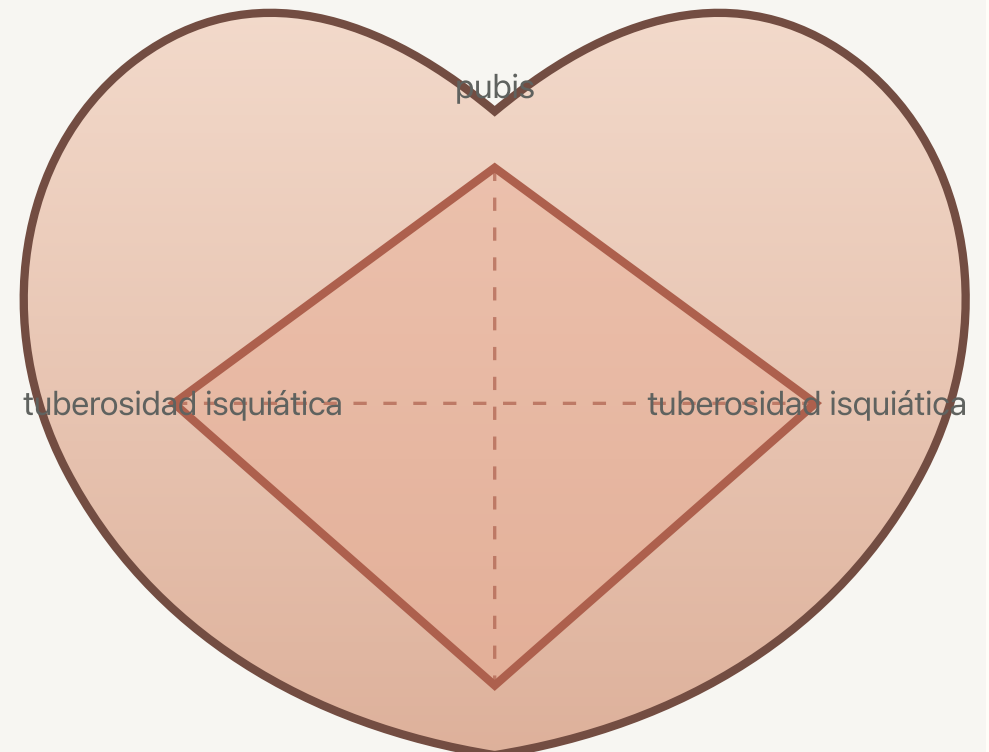
- Sínfisis púbica anterior.
- Tuberosidades isquiáticas laterales.
- Cóccix posterior.

RELACIÓN SUPERFICIAL

Piel, fascia y musculatura del suelo pélvico; se distinguen lados derecho e izquierdo.

PRECISIÓN

Siempre opcional, con consentimiento explícito, explicación previa, privacidad y registro si se omite.



PUNTO 30 • MIEMBRO SUPERIOR

Región supraolecraniana

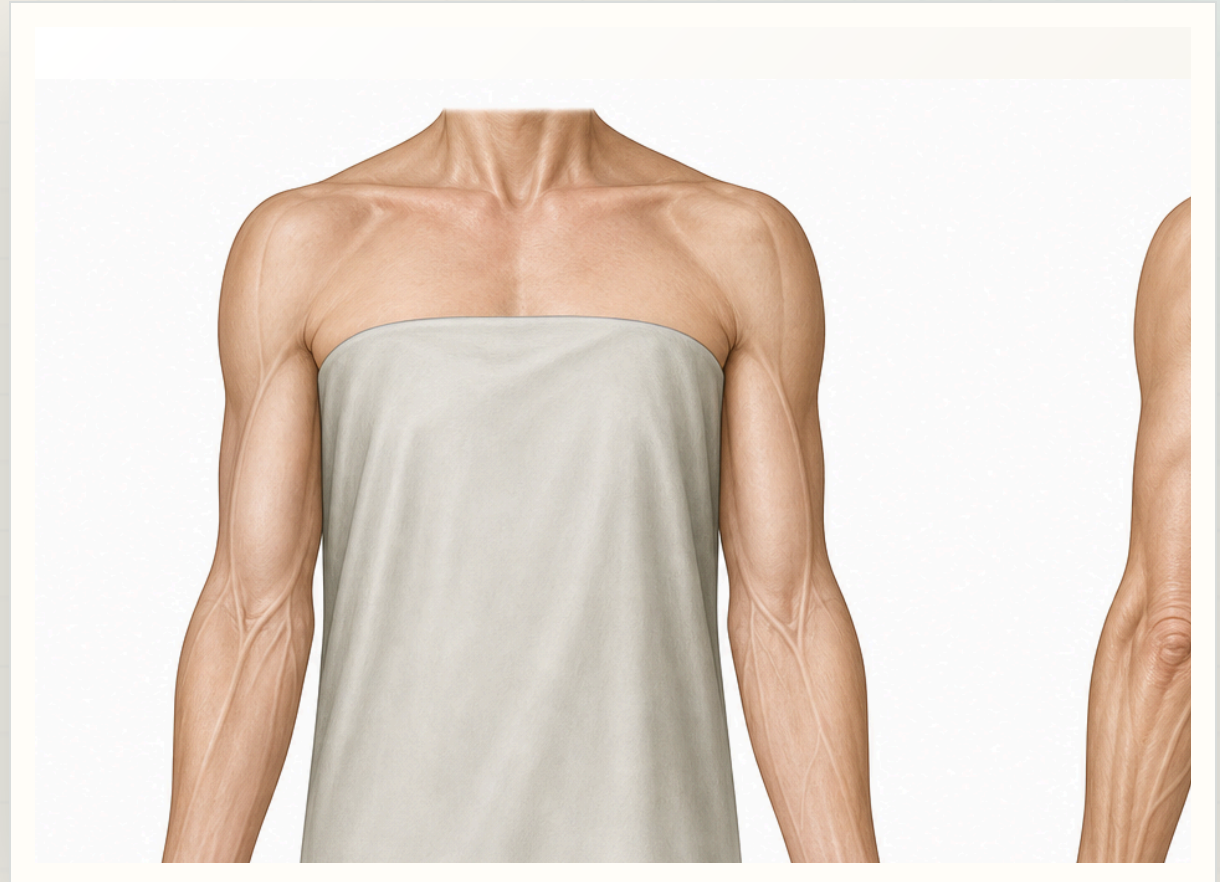
Cara posterior del brazo distal, inmediatamente por encima del olécranon.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Olécranon como prominencia del codo.
- Tendón del tríceps por arriba.
- Cara posterior del húmero distal.

RELACIÓN SUPERFICIAL Tendón del tríceps y bolsa olecraniana superficial en la proximidad.

PRECISIÓN No colocar presión directa sobre una bursa inflamada o un olécranon doloroso.



PUNTO 31 • MIEMBRO SUPERIOR

Fosa antecubital

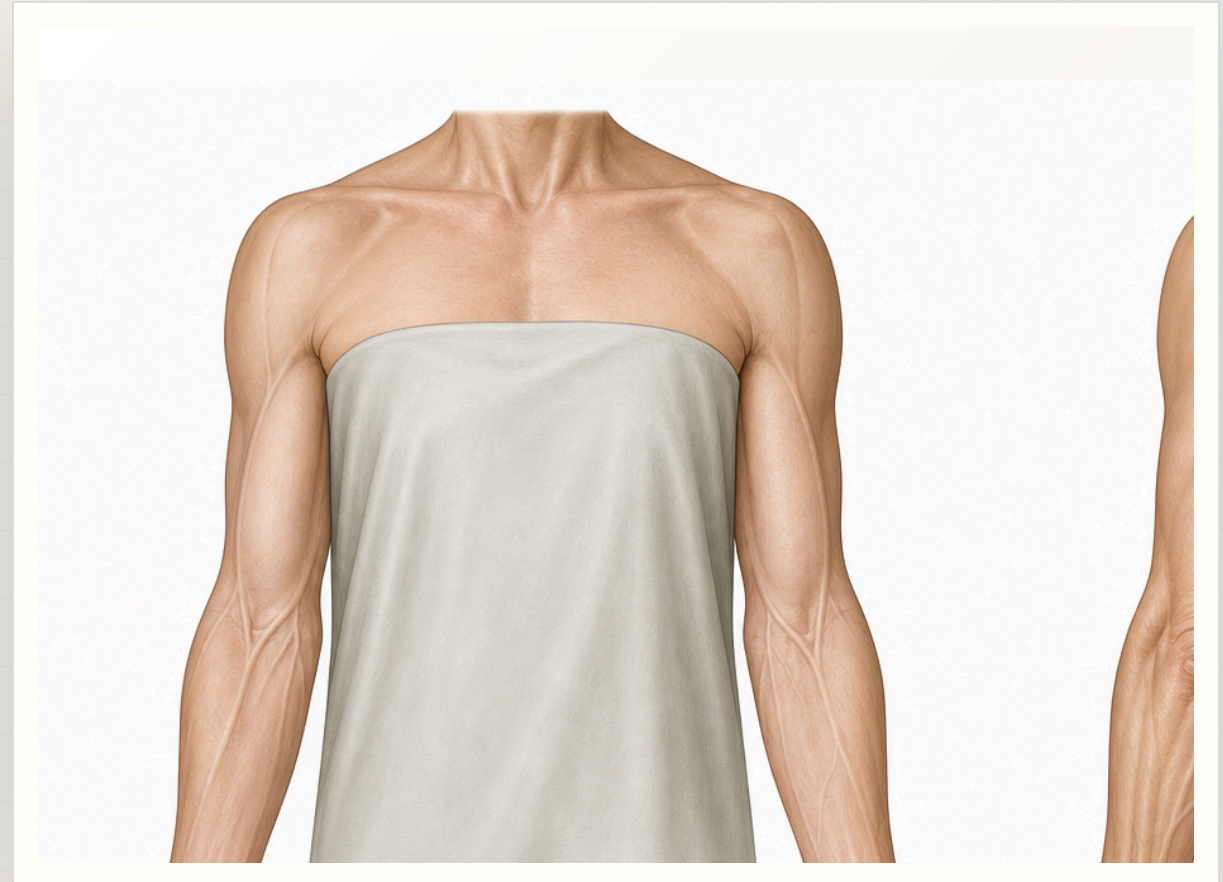
Depresión triangular de la cara anterior del codo.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Bíceps y línea entre epicóndilos como límite superior.
- Braquiorradial lateralmente.
- Pronador redondo medialmente.

RELACIÓN SUPERFICIAL Tendón del bíceps, arteria braquial y nervio mediano en planos superficiales y profundos.

PRECISIÓN No se comprime la arteria braquial ni se trabaja sobre una venopunción reciente.



PUNTO 32 • MIEMBRO SUPERIOR

Tercio distal anterior del antebrazo

Tercio de la cara palmar del antebrazo más cercano a la muñeca.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

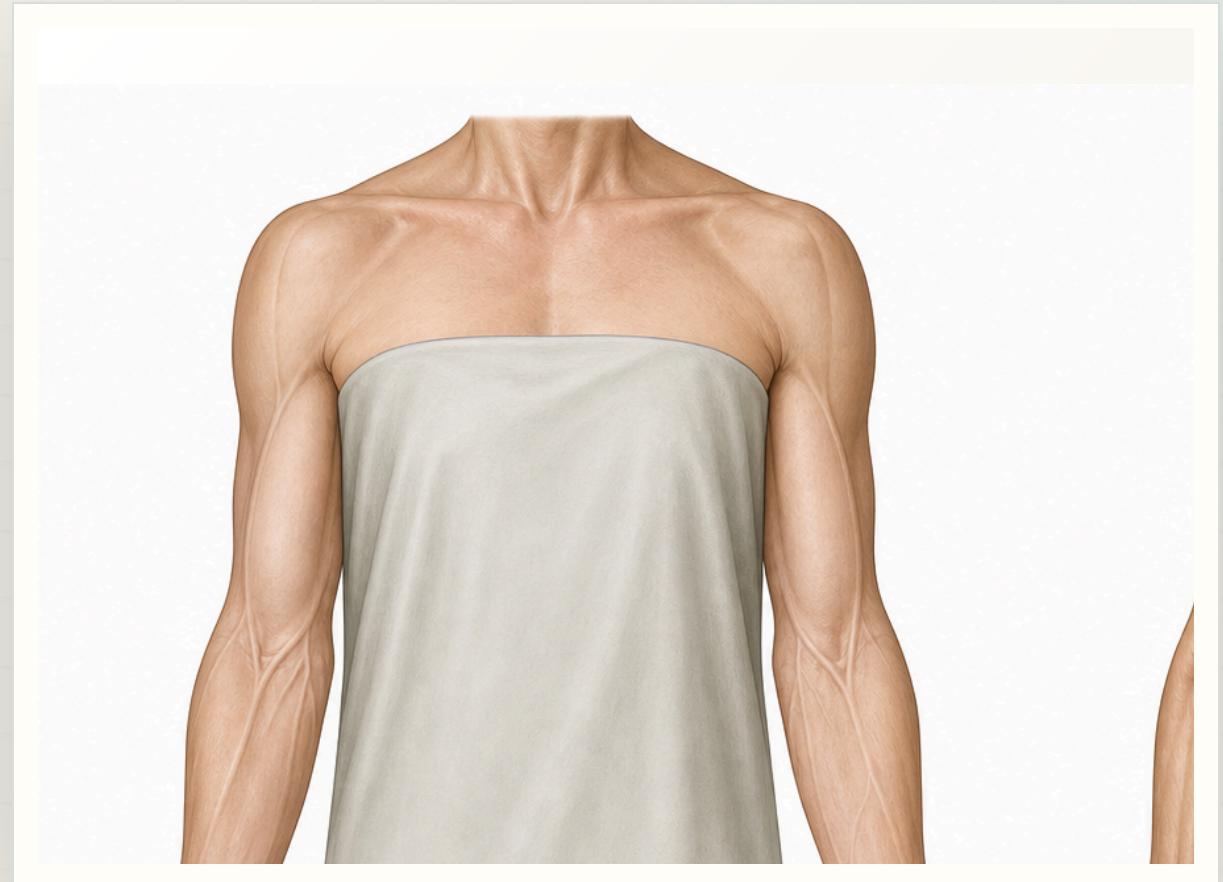
- Pliegue de la muñeca como límite distal.
- Eje entre radio y cúbito.
- Tendones flexores visibles al mover los dedos.

RELACIÓN SUPERFICIAL

Tendones flexores; arterias radial y cubital discurren a cada lado.

PRECISIÓN

El documento no fija lado radial, central o cubital; debe registrarse la posición exacta que marque.



PUNTO 33 • MIEMBRO SUPERIOR

Área de las muñecas

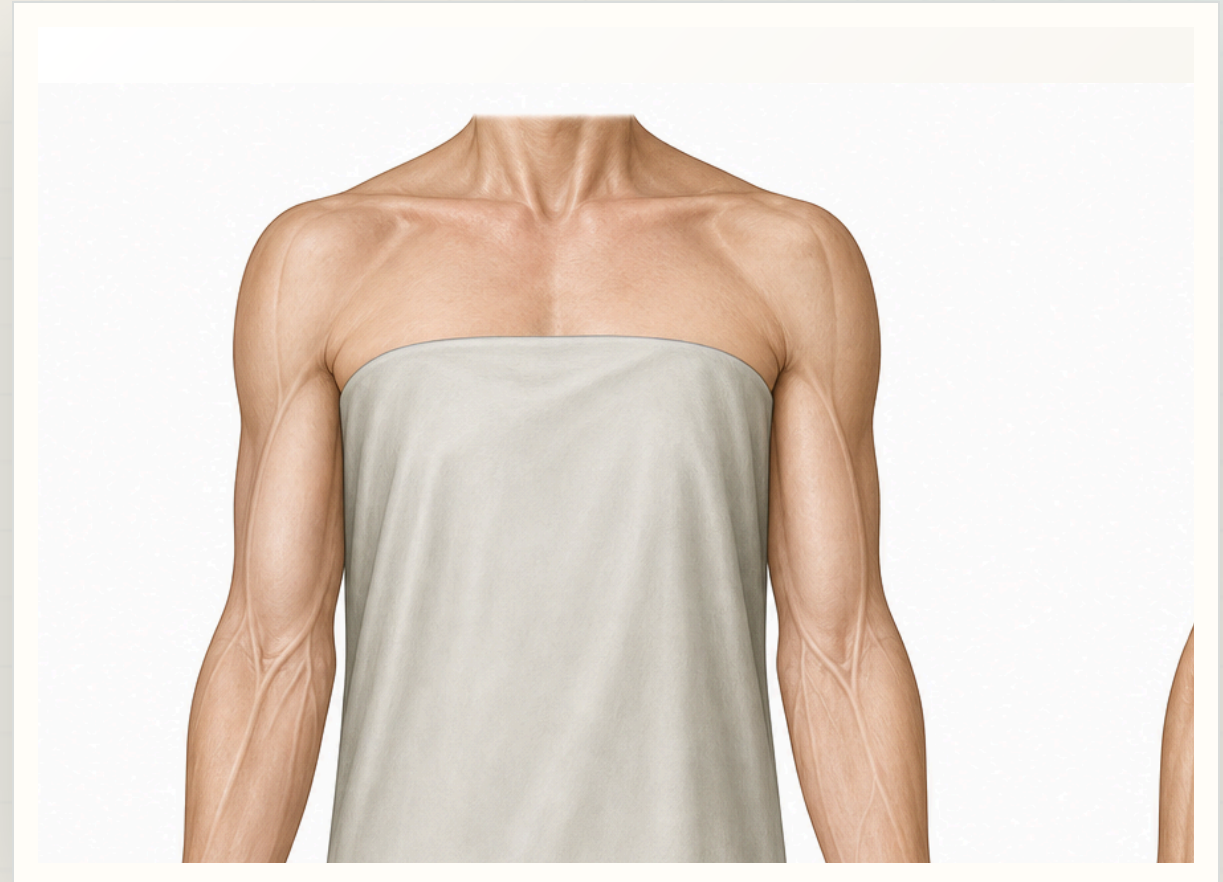
Región que rodea la articulación radiocarpiana y los pliegues de la muñeca.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Apófisis estiloides radial.
- Apófisis estiloides cubital.
- Pliegue palmar proximal y dorso del carpo.

RELACIÓN SUPERFICIAL Tendones flexores y extensores, retináculos y paquetes neurovasculares superficiales.

PRECISIÓN "Área" no especifica cara palmar o dorsal; se debe anotar dónde apareció la respuesta.



PUNTO 34 • MIEMBRO SUPERIOR

Dorso de la mano

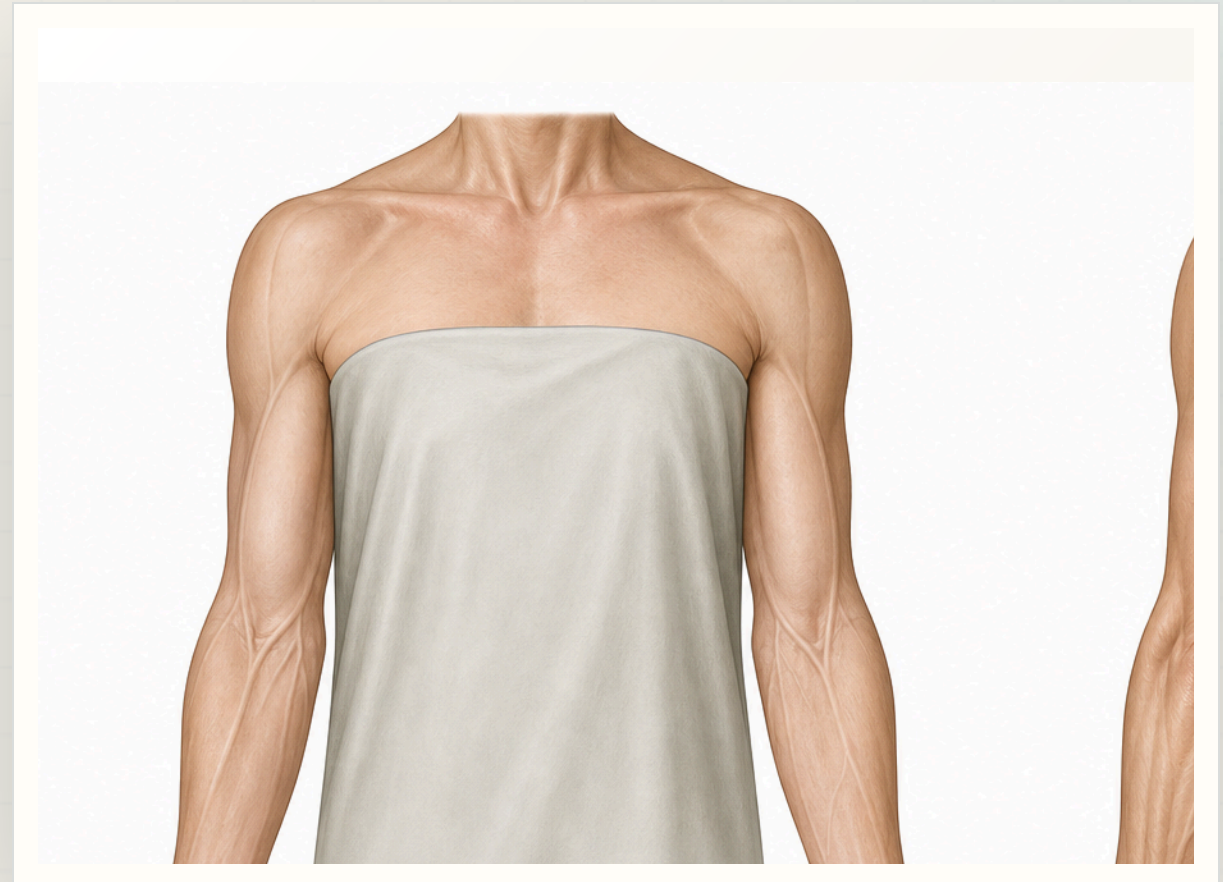
Superficie posterior de la mano, entre la muñeca y las articulaciones metacarpofalángicas.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Bases y ejes de los metacarpianos.
- Tendones extensores visibles al extender los dedos.
- Red venosa dorsal superficial.

RELACIÓN SUPERFICIAL Piel fina, venas dorsales, tendones extensores y metacarpianos.

PRECISIÓN Evitar presión sobre venas prominentes, lesiones cutáneas o articulaciones inflamadas.



PUNTO 35 • MIEMBRO INFERIOR

Tensor de la fascia lata

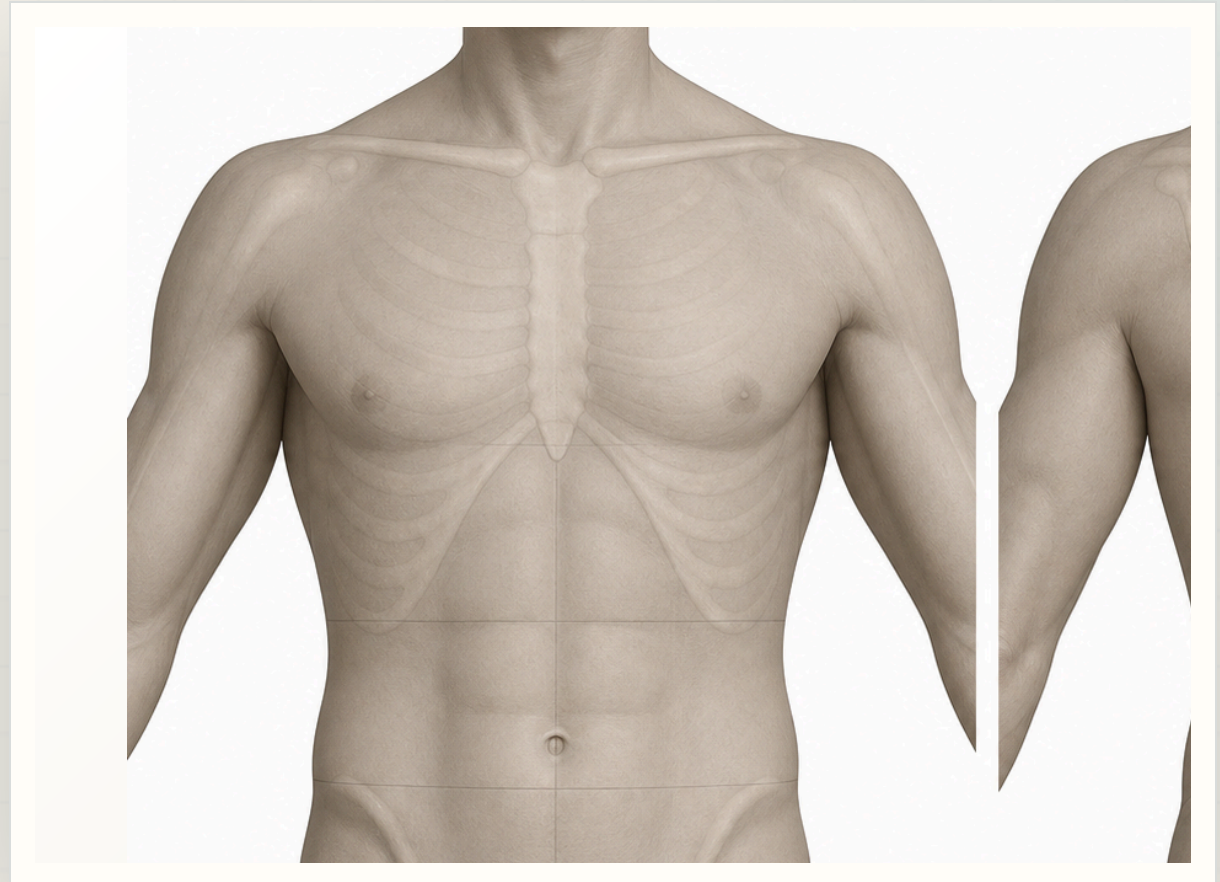
Región anterolateral proximal del muslo, entre la EIAS y el tracto iliotibial.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- EIAS por arriba y anterior.
- Trocánter mayor posterior e inferior.
- Banda iliotibial descendiendo por la cara lateral del muslo.

RELACIÓN SUPERFICIAL Músculo tensor de la fascia lata, superficial en la cadera anterolateral.

PRECISIÓN No es "toda la parte lateral de la pierna"; el músculo se concentra en la porción proximal del muslo.



PUNTO 36 • MIEMBRO INFERIOR

Ojos de la rodilla

Recesos parapatelares palpables alrededor de la rótula.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Borde medial y lateral de la rótula.
- Recesos superiores e inferiores.
- Tendones cuadricipital y rotuliano como límites verticales.

RELACIÓN SUPERFICIAL Retináculos patelares, cápsula y recesos sinoviales.

PRECISIÓN El dictado menciona cuatro depresiones; no se presiona una rodilla inflamada o con derrame.



PUNTO 37 • MIEMBRO INFERIOR

Hueco poplíteo

Depresión romboidal situada detrás de la rodilla.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Tendones isquiotibiales superiores.
- Cabezas del gastrocnemio inferiores.
- Pliegue posterior de la rodilla.

RELACIÓN SUPERFICIAL Arteria y vena poplíteas y nervios tibial y fibular común atraviesan la fosa.

PRECISIÓN Zona neurovascular: no se realiza compresión profunda ni sostenida.



PUNTO 38 • MIEMBRO INFERIOR

Tendón de Aquiles

Cordón tendinoso posterior que une la pantorrilla con el calcáneo.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Gastrocnemio y sóleo por arriba.
- Tuberosidad posterior del calcáneo por abajo.
- Línea media posterior del tobillo.

RELACIÓN SUPERFICIAL Tendón calcáneo y paratendón superficial.

PRECISIÓN

No aplicar presión sobre rotura, tendinopatía aguda o inflamación evidente.



PUNTO 39 • MIEMBRO INFERIOR

Canal retromaleolar

Surco situado detrás de un maléolo y por delante del tendón de Aquiles.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Maléolo medial o lateral.
- Tendón de Aquiles posterior.
- Surco blando entre ambas referencias.

RELACIÓN SUPERFICIAL En el lado medial pasan tendones flexores, vasos tibiales posteriores y nervio tibial; en el lateral, tendones fibulares.

PRECISIÓN El documento no especifica maléolo medial o lateral; deben registrarse lado y canal exactos.



PUNTO 40 • MIEMBRO INFERIOR

Empeine

Superficie dorsal del mediopié, entre el tobillo y las bases de los dedos.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Articulación del tobillo proximal.
- Metatarsianos y tendones extensores.
- Arco dorsal del pie.

RELACIÓN SUPERFICIAL Tendones extensores y arteria dorsal del pie en el dorso.

PRECISIÓN

“Empeine” es un término superficial amplio; se registra el lugar exacto que responde.



PUNTO 41 • MIEMBRO INFERIOR

Planta del pie

Superficie inferior del pie, desde el calcáneo hasta las cabezas metatarsianas y los dedos.

REFERENCIAS ANATÓMICAS

- Talón posterior.
- Arco longitudinal medial.
- Cabezas metatarsianas anteriores.

RELACIÓN SUPERFICIAL Aponeurosis plantar, almohadillas grasas y ramas nerviosas plantares.

PRECISIÓN No es un solo punto anatómico; deben registrarse subregión, lado y sensibilidad de la piel.

